

眼科学·期末题库

眼科学·期末题库 (batch037) 题库 (200题)

来源：最终产物\batch037\ALL_questions_FIXED.json | 导出：2026-09-30 11:44

题型分布：A1×81、A2×58、B1×22、A3×10、A4×10、X×10、判断×9

Bloom分布：理解×80、记忆×60、应用×50、分析×10

M1 (20题)

1. [A1型题 | 理解] batch037-M1-A1-001

模块：M1 | 页码：教材P19

角膜组织学各层中，损伤后不能再生的是？

- A. 上皮细胞层
- **B. 前弹力层** ✓
- C. 角膜基质层
- D. 后弹力层
- E. 内皮细胞层

答案：B

解析：前弹力层（Bowman膜）为均质无细胞成分的透明膜，由基质中角膜细胞分泌形成，损伤后不能再生；上皮细胞层再生快且不留痕迹，后弹力层由内皮细胞分泌、损伤后可再生，内皮损伤主要靠邻近细胞移行扩展填补。教材P19。

2. [A1型题 | 记忆] batch037-M1-A1-002

模块：M1 | 页码：教材P15

下列眼外肌中，受滑车神经（第IV对脑神经）支配的是？

- A. 内直肌
- B. 外直肌
- C. 上直肌
- **D. 上斜肌** ✓
- E. 下斜肌

答案：D

解析：外直肌受第VI对展神经支配，上斜肌受第IV对滑车神经支配，其余眼外肌（内直、上直、下直、下斜肌）均受第III对动眼神经支配。教材P15。

3. [A1型题 | 理解] batch037-M1-A1-003

模块：M1 | 页码：教材P7

前房角小梁网中，房水外流的主要阻力部位是？

- A. 葡萄膜部小梁
- B. 角巩膜部小梁
- C. 近小管组织 ☒
- D. Schlemm管腔
- E. 睫状带隐窝

答案：C

解析：滤过房水的小梁网分葡萄膜部（前房侧）、角巩膜部和近小管组织（Schlemm管侧）三部分，其中近小管组织是房水外流的主要阻力部位；Schlemm管为围绕前房角一周的房水输出管道。教材P7。

4. [A1型题 | 记忆] batch037-M1-A1-004

模块：M1 | 页码：教材P35

用直径3mm白色视标检查，正常人下方周边视野约为？

- A. 55°
- B. 60°
- C. 70° ☒
- D. 80°
- E. 90°

答案：C

解析：用直径3mm白色视标检查周边视野正常值为上方55°、下方70°、鼻侧60°、颞侧90°；改用蓝、红、绿色视标时周边视野依次递减约10°。教材P35。

5. [A1型题 | 理解] batch037-M1-A1-005

模块：M1 | 页码：教材P48

目前国际公认、被视为眼压测量“金标准”的眼压计是？

- A. 压陷式Schiötz眼压计
- **B. Goldmann压平眼压计** ✓
- C. 喷气式非接触眼压计
- D. Tono-Pen手持笔式眼压计
- E. Perkin手持压平眼压计

答案：B

解析：Goldmann压平眼压计附装于裂隙灯，将角膜压平至直径3.06mm时读数，眼球容积改变小、受球壁硬度影响小，是眼压测量的金标准；Schiötz属压陷式，测量值受眼球壁硬度影响较大。教材P48。

6. [A1型题 | 理解] batch037-M1-A1-006

模块：M1 | 页码：教材P22

关于视网膜视杆细胞与视锥细胞，错误的是？

- A. 视锥细胞主要集中于黄斑区
- B. 黄斑中心凹处只有视锥细胞
- C. 视杆细胞感弱光与无色视觉
- **D. 视盘处富含视杆细胞** ✓
- E. 周边视网膜病变可致夜盲

答案：D

解析：视盘（视乳头）处无视杆、视锥等感光细胞，无视觉功能，在视野中表现为生理盲点；视锥细胞集中于黄斑、中心凹仅有视锥细胞，视杆细胞感弱光和无色视觉，周边部视网膜病变致视杆受损时发生夜盲。教材P22。

7. [A1型题 | 理解] batch037-M1-A1-007

模块：M1 | 页码：教材P48

Scheie分级法中，静态下能看见房角全部结构（Schwalbe线、小梁网、巩膜突、睫状体带）者称为？

- A. 窄 I
- B. 窄 II
- C. 窄 III

- D. 窄IV
- E. 宽角 ☒

答案：E

解析：Scheie分级强调房角镜下静态可见的最后部结构：能看见房角全部结构者为宽角，否则为窄角；窄角随狭窄程度增加分为窄Ⅰ至窄Ⅳ，动态下可进一步判断房角开放或关闭。教材P48。

8. [A1型题 | 理解] batch037-M1-A1-008

模块：M1 | 页码：教材P40

闪光视网膜电图（ERG）中，b波振幅下降而a波振幅正常，常提示？

- A. 视网膜外层损害
- B. 视网膜内层功能障碍 ☒
- C. 脉络膜毛细血管病变
- D. 视神经脱髓鞘病变
- E. 视皮质神经元病变

答案：B

解析：闪光ERG的a波起源于光感受器（视网膜外层），b波起源于双极细胞与Müller细胞（视网膜内层）；b波降而a波正常提示视网膜内层功能障碍，见于先天性静止性夜盲、青少年视网膜劈裂、视网膜中央动静脉阻塞等。教材P40。

9. [A2型题 | 应用] batch037-M1-A2-001

模块：M1 | 页码：教材P31

患者，男，58岁，无明显诱因突发右眼视力下降，不伴眼痛、畏光。眼底检查见灰白色隆起。最可能的诊断是？

- A. 急性闭角型青光眼
- B. 急性虹膜睫状体炎
- C. 细菌性角膜炎
- D. 视网膜脱离 ☒
- E. 化脓性眼内炎

答案：D

解析：急性视力下降不伴疼痛可见于视网膜动脉或静脉阻塞、缺血性视神经病变、玻璃体积血、视网膜脱离、视神经炎；伴眼痛者见于急性闭角型青光眼、葡萄膜炎、角膜炎、眼内炎。视网膜灰白色隆起为视网膜脱离典型眼底表现。教材P31。

10. [A2型题 | 理解] batch037-M1-A2-002

模块：M1 | 页码：教材P22

患者诉夜间及暗处视物困难，眼底检查发现周边视网膜色素变性。其夜盲主要累及的感光细胞是？

- A. 视锥细胞
- **B. 视杆细胞** ✓
- C. 双极细胞
- D. 神经节细胞
- E. Müller细胞

答案：B

解析：视杆细胞感弱光（暗视觉）和无色视觉，在中心凹处缺乏、距中心凹约5mm处最多；当周边部视网膜病变致视杆细胞受损时即发生夜盲。视锥细胞感强光和色觉，黄斑病变时表现为中心视力与色觉下降。教材P22。

11. [A2型题 | 应用] batch037-M1-A2-003

模块：M1 | 页码：教材P34

检影验光时工作距离为50cm，被检眼达到中和点时所用镜片度数为+3.00D，其实际屈光不正度数？

- A. +0.50D
- **B. +1.00D** ✓
- C. +1.50D
- D. +2.00D
- E. +3.00D

答案：B

解析：检影达中和后须减去工作距离对应的屈光度：工作距离50cm对应+2.00D，故实际屈光不正度数=+3.00D-（+2.00D）=+1.00D。教材P34。

12. [A2型题 | 记忆] batch037-M1-A2-004

模块：M1 | 页码：教材P37

升学体检中欲快速筛查受检者有无红绿色觉异常，最简单、最常用的检查方法是？

- A. 假同色图检查 ☒
- B. Farnsworth D-15排列
- C. 色盲镜检查
- D. 视觉诱发电位
- E. 视网膜电图

答案：A

解析：假同色图（色盲本）检查为最简单、快速并广泛应用的色觉检测方法，利用正常色觉者以颜色辨认、异常者以明暗判断的原理；色相排列检测与色盲镜检查更精确但费时。先天性色觉障碍多为性连锁隐性遗传，最常见为红绿色弱（盲）。教材P37。

13. [A2型题 | 应用] batch037-M1-A2-005

模块：M1 | 页码：教材P43

患者左眼视力下降，用手电筒交替照射双眼时，光照右眼双眼瞳孔缩小，光照左眼双眼瞳孔不缩小。该体征提示？

- A. 左眼视神经病变 ☒
- B. 左眼动眼神经麻痹
- C. 右眼视神经病变
- D. 双侧睫状肌麻痹
- E. 瞳孔括约肌损伤

答案：A

解析：相对性传入性瞳孔障碍（RAPD，Marcus-Gunn瞳孔）指光照患眼时双眼瞳孔不缩小、照健眼时双眼缩小，提示患侧视神经（传入路）病变，常见于单眼球后视神经炎、缺血性视神经病变、晚期青光眼。本例患眼为左眼。教材P43。

14. [A2型题 | 应用] batch037-M1-A2-006

模块：M1 | 页码：教材P31

下列各项中，不属于急性视力下降伴眼痛常见病因的是？

- A. 急性闭角型青光眼
- B. 急性葡萄膜炎
- C. 细菌性角膜炎
- **D. 视网膜中央动脉阻塞** ✓
- E. 化脓性眼内炎

答案：D

解析：急性视力下降伴眼痛见于急性闭角型青光眼、葡萄膜炎、角膜炎、眼内炎，球后视神经炎可伴眼球转动痛；视网膜中央动脉阻塞表现为急性无痛性视力骤降，属不伴眼痛的急性视力下降病因。教材P31。

15. [A3型题 | 应用] batch037-M1-A3-001

模块：M1 | 页码：教材P3

患者，女，68岁，傍晚突发右眼剧烈胀痛伴同侧头痛、恶心呕吐，视物模糊并看灯光有彩虹样光环，既往有远视。查体见右眼混合充血、角膜雾状混浊、前房浅、瞳孔中度散大固定。为明确诊断，最紧急且首选的检查是？

- A. 电脑视野检查
- **B. 眼压测量** ✓
- C. 眼底荧光血管造影
- D. 眼B型超声检查
- E. 角膜地形图检查

答案：B

解析：老年人傍晚突发眼胀痛伴头痛、恶心呕吐、虹视，为急性闭角型青光眼急性发作的典型表现，全身症状易误诊为神经或消化系疾病；应立即以指测法或眼压计测量眼压，并配合前房角镜检查房角开闭。教材P3。

16. [A4型题 | 分析] batch037-M1-A4-001

模块：M1 | 页码：教材P41

患者，女，26岁，1周前“感冒”后出现右眼视力进行性下降，眼球转动时疼痛。查体：右眼视力0.1，瞳孔直接对光反射减弱、间接存在，眼底视盘边界基本正常，头颅CT未见占位病变。为客观评估视神经传导功能，最有价值的检查是？

- A. 闪光视网膜电图
- **B. 视觉诱发电位** ✓

- C. 眼电图
- D. 对比敏感度检查
- E. 暗适应检查

答案：B

解析：青年患者感染后急性视力下降伴眼球转动痛而眼底基本正常，提示球后视神经炎；视觉诱发电位（VEP）代表神经节细胞以上视觉信息的传导，脱髓鞘性视神经炎表现为P100波潜伏期延长而振幅常正常，是客观评估视神经功能、鉴别伪盲的重要检查。教材P41。

17. [B1型题 | 记忆] batch037-M1-B1-001

模块：M1 | 页码：教材P40

闪光视网膜电图（ERG）的a波主要起源于？

- A. 光感受器细胞 ☒
- B. 双极细胞
- C. 无长突细胞
- D. 神经节细胞
- E. 视网膜色素上皮

答案：A

解析：闪光ERG的a波起源于光感受器细胞，b波起源于双极细胞与Müller细胞，振荡电位（OPs）起源于无长突细胞；图形ERG与神经节细胞相关。教材P40。

18. [B1型题 | 记忆] batch037-M1-B1-002

模块：M1 | 页码：教材P40

眼电图（EOG）主要产生于？

- A. 光感受器细胞
- B. 双极细胞
- C. 无长突细胞
- D. 神经节细胞
- E. 视网膜色素上皮 ☒

答案：E

解析：眼电图（EOG）记录眼的静息电位，产生于视网膜色素上皮；VEP反映视神经及视路功能，EOG异常见于视网膜色素上皮与光感受器细胞疾病。教材P40。

19. [X型题 | 理解] batch037-M1-X-001

模块：M1 | 页码：教材P11

下列结构中，属于眼屈光介质的有？

- A. 角膜 ☒
- B. 房水 ☒
- C. 晶状体 ☒
- D. 玻璃体 ☒
- E. 巩膜

答案：ABCD

解析：眼球内容物房水、晶状体、玻璃体三种透明物质，与角膜一并称为眼的屈光介质，是光线进入眼内到达视网膜的通路；巩膜为外层乳白色纤维膜，不透明，无屈光作用。教材P11。

20. [判断题 | 记忆] batch037-M1-判断-001

模块：M1 | 页码：教材P49

间接检眼镜检查所见眼底为正像，放大约16倍。

- A. 正确
- B. 错误 ☒

答案：B

解析：直接检眼镜所见眼底为正像、放大约16倍；双目间接检眼镜所见为倒像（上下左右均相反），放大仅3~4倍，但具有立体感、可见范围更大。教材P49。

M2（20题）

21. [A1型题 | 记忆] batch037-M2-A1-001

模块：M2 | 页码：教材P57

睑腺炎最常见的致病菌是？

- A. 铜绿假单胞菌
- **B. 金黄色葡萄球菌** ☒
- C. 肺炎链球菌
- D. 白念珠菌
- E. 淋病双球菌

答案：B

解析：睑腺炎多为葡萄球菌感染，尤以金黄色葡萄球菌最常见，可引起眼睑急性化脓性炎症。教材P57。

22. [A1型题 | 记忆] batch037-M2-A1-002

模块：M2 | 页码：教材P57

内睑腺炎是下列哪一腺体的急性化脓性感染？

- **A. 睑板腺** ☒
- B. Zeis腺
- C. Moll腺
- D. Krause副泪腺
- E. 结膜杯状细胞

答案：A

解析：睑板腺感染称内睑腺炎；睫毛毛囊附属Zeis腺或变态汗腺Moll腺感染称外睑腺炎。教材P57。

23. [A1型题 | 理解] batch037-M2-A1-003

模块：M2 | 页码：教材P57

外睑腺炎脓肿形成后，皮肤面切开排脓的切口应？

- A. 与睑缘垂直
- B. 与角膜缘平行
- **C. 与睑缘平行** ☒
- D. 呈环形切开
- E. 与眶缘平行

答案：C

解析：外睑腺炎切口在皮肤面，与睑缘平行、与皮纹一致以减少瘢痕；内睑腺炎切口在睑结膜面，与睑缘垂直以免伤及睑板腺管。教材P57。

24. [A1型题 | 理解] batch037-M2-A1-004

模块：M2 | 页码：教材P57

睑板腺囊肿（霰粒肿）的病变性质属于？

- A. 急性细菌性化脓性炎症
- B. 病毒感染性炎症
- C. 接触性超敏反应炎症
- D. 特发性无菌性慢性肉芽肿炎症 ☒
- E. 真菌感染性炎症

答案：D

解析：睑板腺囊肿是特发性、无菌性、慢性肉芽肿性炎症，无急性红肿痛，可与急性睑腺炎相鉴别。教材P57。

25. [A1型题 | 理解] batch037-M2-A1-005

模块：M2 | 页码：教材P61

重症肌无力所致获得性上睑下垂，典型特点是？

- A. 晨轻暮重、新斯的明试验阳性 ☒
- B. 出生后即双眼完全对称
- C. 伴同侧Horner综合征
- D. 注射新斯的明后加重
- E. 上睑遮盖角膜上缘约1mm

答案：A

解析：重症肌无力性上睑下垂晨轻夜重，注射新斯的明后明显减轻；Horner综合征见于交感神经损害。教材P61。

26. [A1型题 | 记忆] batch037-M2-A1-006

模块：M2 | 页码：教材P67

慢性泪囊炎最好发于哪类人群？

- A. 青年男性
- B. 婴幼儿
- C. 学龄儿童
- D. 青年女性
- E. 中老年女性 ☒

答案：E

解析：慢性泪囊炎多见于中老年女性，是最常见的泪囊病，多继发于鼻泪管狭窄或阻塞。教材P67。

27. [A1型题 | 应用] batch037-M2-A1-007

模块：M2 | 页码：教材P66

泪道冲洗时冲洗液完全从注入原路反流，提示？

- A. 鼻泪管狭窄
- B. 泪小管阻塞 ☒
- C. 泪总管阻塞
- D. 泪道通畅
- E. 合并慢性泪囊炎

答案：B

解析：冲洗液完全从注入原路反流为泪小管阻塞；上、下泪小点间互流反流提示泪总管、泪囊或鼻泪管阻塞。教材P66。

28. [A1型题 | 记忆] batch037-M2-A1-008

模块：M2 | 页码：教材P63

泪膜的构成成分不包括？

- A. 脂质层
- B. 水液层
- C. 纤维蛋白层 ☒
- D. 黏蛋白层
- E. 弹性纤维层

答案：C

解析：泪膜由睑板腺分泌的脂质（睑酯）层、副泪腺分泌的水液层和结膜杯状细胞分泌的黏蛋白层构成，不含纤维蛋白层。教材P63。

29. [A2型题 | 应用] batch037-M2-A2-001

模块：M2 | 页码：教材P57

患者左眼睑缘处红、肿、痛2天，触之硬结明显，尚未形成脓点。早期首选处理是？

- A. 立即用力挤压排脓
- B. 脓点形成后尽早切开排脓
- C. 局部热敷并滴抗生素滴眼剂 ☒
- D. 全身大剂量糖皮质激素冲击
- E. 病灶局部冷冻治疗

答案：C

解析：早期睑腺炎应予局部热敷、每日滴抗生素滴眼剂；脓肿未形成时不宜切开或挤压，以免感染扩散。教材P57。

30. [A2型题 | 理解] batch037-M2-A2-002

模块：M2 | 页码：教材P57

患者右上睑皮下无痛性圆形硬结3周，无急性红肿痛，与皮肤无粘连。最可能诊断是？

- A. 睑腺炎
- B. 睑缘炎
- C. 基底细胞癌
- D. 睑板腺癌
- E. 睑板腺囊肿 ☒

答案：E

解析：睑板腺囊肿为特发性慢性肉芽肿，表现为皮下无痛性硬结、无急性炎症，可与急性睑腺炎鉴别；反复复发者需警惕皮脂腺癌。教材P57。

31. [A2型题 | 应用] batch037-M2-A2-003

模块：M2 | 页码：教材P60

婴幼儿双下睑内翻伴倒睫，角膜上皮轻度荧光素着染。正确的处理原则是？

- A. 及早行睑板切除手术矫正
- **B. 随年龄增长多可自行消失** ✓
- C. 局部浅层放射治疗
- D. 病灶局部冷冻治疗
- E. 持续滴用缩瞳药

答案：B

解析：先天性睑内翻随年龄增长、鼻梁发育多可自行消失，不必急于手术；长期严重刺激引起角膜损伤者才考虑手术。教材P60。

32. [A2型题 | 理解] batch037-M2-A2-004

模块：M2 | 页码：教材P61

患者因周围性面神经麻痹出现下睑外翻、溢泪，睑结膜暴露充血。关键治疗措施是？

- A. 睑板楔形切除
- B. 泪囊鼻腔吻合术
- C. 提上睑肌缩短术
- **D. 治疗面瘫并涂眼膏保护角膜** ✓
- E. 内眦赘皮矫正术

答案：D

解析：麻痹性睑外翻源于面神经麻痹，关键在于治疗面瘫，并用眼膏、牵拉眼睑保护角膜，必要时行暂时性睑缘缝合术。教材P61。

33. [A2型题 | 应用] batch037-M2-A2-005

模块：M2 | 页码：教材P67

老年女性溢泪多年，挤压泪囊有脓性分泌物。拟行白内障手术。下列处理错误的是？

- A. 术前先治疗慢性泪囊炎
- B. 取反流分泌物涂片查菌
- C. 先行泪囊鼻腔吻合术后再手术
- **D. 可直接安排内眼手术** ✓
- E. 术前常规检查泪道情况

答案：D

解析：慢性泪囊炎是内眼手术的禁忌证，其带菌分泌物可逆行进结膜囊，术中术后易致化脓性眼内炎，术前必须先治疗泪囊炎，不能直接手术。教材P67。

34. [A2型题 | 记忆] batch037-M2-A2-006

模块：M2 | 页码：教材P64

行Schirmer I 试验前不点表面麻醉剂，滤纸条浸润长度短于多少提示异常？

- A. 短于5mm
- B. 短于10mm ☒
- C. 短于15mm
- D. 短于20mm
- E. 短于25mm

答案：B

解析：不点麻醉剂时Schirmer I 评价泪腺反射分泌功能，短于10mm为异常；点麻醉剂评价副泪腺基础分泌，短于5mm为异常。教材P64。

35. [A3型题 | 理解] batch037-M2-A3-001

模块：M2 | 页码：教材P63

患者右上睑外侧红肿疼痛3天，上睑水肿下垂呈横“S”形，提起上睑见颞上方结膜充血水肿，耳前淋巴结肿大、伴发热。最可能的诊断是？

- A. 急性泪囊炎
- B. 眶蜂窝织炎
- C. 急性泪腺炎 ☒
- D. 睑腺炎
- E. 慢性泪腺炎

答案：C

解析：急性泪腺炎表现为上睑外侧红肿疼痛、上睑呈横“S”形、颞上方结膜充血、耳前淋巴结肿大，多单侧、儿童和青年多见。教材P63。

36. [A4型题 | 分析] batch037-M2-A4-001

模块：M2 | 页码：教材P66

老年女性长期溢泪，无泪囊区红肿热痛。挤压泪囊有黏液脓性分泌物自下泪小点流出；泪道冲洗时冲洗液自下泪小点注入后由上泪小点反流，并伴脓性分泌物。该患者最准确的诊断是？

- A. 单纯泪小管阻塞
- B. 泪总管阻塞伴泪囊扩张
- C. 单纯鼻泪管狭窄
- D. 单纯鼻泪管阻塞
- E. 鼻泪管阻塞合并慢性泪囊炎 ☒

答案：E

解析：上、下泪小点间互流反流提示阻塞位于泪总管以下（泪囊或鼻泪管）；反流同时伴黏脓性分泌物提示合并慢性泪囊炎；无急性红肿热痛可排除急性泪囊炎。教材P66。

37. [B1型题 | 理解] batch037-M2-B1-001

模块：M2 | 页码：教材P58

睑缘充血潮红、睫毛根部蜡样皮脂痂皮，无溃疡脓点，睫毛脱落但可再生。诊断为？

- A. 非感染性睑缘炎 ☒
- B. 感染性睑缘炎
- C. 接触性睑皮炎
- D. 带状疱疹病毒性睑皮炎
- E. 睑板腺囊肿

答案：A

解析：非感染性睑缘炎表现为睑缘充血、皮脂溢出结痂，无溃疡脓点，睫毛脱落可再生；感染性者有脓疱溃疡、毛囊破坏致秃睫。教材P58。

38. [B1型题 | 理解] batch037-M2-B1-002

模块：M2 | 页码：教材P58

睫毛根部散布小脓疱、有痂皮覆盖，去痂后见浅小溃疡，毛囊破坏形成秃睫。诊断为？

- A. 非感染性睑缘炎
- B. 感染性睑缘炎 ☒
- C. 接触性睑皮炎
- D. 带状疱疹病毒性睑皮炎
- E. 睑板腺囊肿

答案：B

解析：感染性睑缘炎多为金黄色葡萄球菌感染，睫毛根部脓疱、浅小溃疡，毛囊被破坏后睫毛不能再生，形成秃睫。教材P58。

39. [X型题 | 应用] batch037-M2-X-001

模块：M2 | 页码：教材P67

关于慢性泪囊炎，下列正确的有？

- A. 多见于中老年女性 ✓
- B. 主要症状为溢泪 ✓
- C. 挤压泪囊有黏脓性分泌物自泪小点流出 ✓
- D. 内眼手术前可不予处理
- E. 首选泪囊鼻腔吻合术恢复泪道通畅 ✓

答案：ABCE

解析：慢性泪囊炎多见于中老年女性，以溢泪为主，挤压泪囊有黏脓性分泌物反流；它是内眼手术禁忌证，术前必须先治疗，首选泪囊鼻腔吻合术。教材P67。

40. [判断题 | 记忆] batch037-M2-判断-001

模块：M2 | 页码：教材P57

外睑腺炎切开排脓时，皮肤面切口应与睑缘垂直。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

答案：B

解析：外睑腺炎皮肤面切口应与睑缘平行（与皮纹一致）以减少瘢痕；与睑缘垂直是内睑腺炎睑结膜面切口的方向。教材P57。

M3 (20题)

41. [A1型题 | 记忆] batch037-M3-A1-001

模块：M3 | 页码：教材P69

结膜炎患者最典型的一组主观症状是？

- A. 眼痛伴视力骤然下降
- B. 剧烈头痛伴恶心呕吐
- **C. 异物感、烧灼感、畏光流泪** ✓
- D. 突发视野向心性缺损
- E. 复视伴眼球转动疼痛

答案：C

解析：结膜炎共同症状为异物感、烧灼感、痒、畏光、流泪；视力骤降、视野缺损、复视转动痛多提示角膜、视神经或眼外肌病变，而非结膜炎典型表现。教材P69。

42. [A1型题 | 记忆] batch037-M3-A1-002

模块：M3 | 页码：教材P70

临床上划分急性与慢性结膜炎的病程时间界限通常为？

- A. 1周以内
- B. 2周以内
- **C. 3周以内** ✓
- D. 4周以内
- E. 6周以内

答案：C

解析：教材规定病程少于3周者为急性结膜炎，超过3周者为慢性结膜炎；急性者多有自限性，慢性者治疗较棘手。教材P70。

43. [A1型题 | 记忆] batch037-M3-A1-003

模块：M3 | 页码：教材P71

发病24小时内、病情危重的超急性细菌性结膜炎，最常见的病原体是？

- **A. 淋病奈瑟菌** ✓
- B. 表皮葡萄球菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 肺炎链球菌
- E. Koch-Weeks杆菌

答案：A

解析：超急性（24小时内）重度细菌性结膜炎由奈瑟菌属引起，以淋病奈瑟菌最常见，其次为脑膜炎奈瑟菌；后者潜伏期短、进展迅猛，可致角膜溃疡甚至穿孔。教材P71。

44. [A1型题 | 理解] batch037-M3-A1-004

模块：M3 | 页码：教材P71

新生儿经产道感染、双眼大量脓性分泌物不断自睑裂流出，俗称“脓漏眼”的结膜炎是？

- A. 急性卡他性结膜炎
- B. 流行性角结膜炎
- C. 新生儿包涵体性结膜炎
- D. 春季角结膜炎
- E. 新生儿淋球菌性结膜炎 ☒

答案：E

解析：新生儿淋球菌性结膜炎潜伏期2~5天，结膜高度水肿、分泌物很快由浆液性转为脓性且量多不断流出，故称“脓漏眼”，常伴耳前淋巴结肿大压痛，可并发角膜溃疡。教材P71。

45. [A1型题 | 记忆] batch037-M3-A1-005

模块：M3 | 页码：教材P74

俗称“阿波罗11号结膜炎”的流行性出血性结膜炎，其病原体主要是？

- A. 腺病毒8型
- B. 肠道病毒70型 ☒
- C. 沙眼衣原体
- D. 单纯疱疹病毒
- E. 金黄色葡萄球菌

答案：B

解析：流行性出血性结膜炎由肠道病毒70型（偶为柯萨奇病毒A24型）引起，潜伏期短（18~48小时）、结膜下出血显著，是暴发流行的自限性眼病。教材P74。

46. [A1型题 | 记忆] batch037-M3-A1-006

模块：M3 | 页码：教材P75

地方性流行性沙眼主要由沙眼衣原体的哪一血清型引起？

- A. 沙眼衣原体D~K血清型
- B. 沙眼衣原体L1~L3血清型
- C. 鹦鹉热衣原体感染
- **D. A、B、Ba、C血清型** ✓
- E. 肺炎衣原体感染

答案：D

解析：地方性流行性沙眼多由A、B、Ba、C抗原型沙眼衣原体所致；D~K型主要引起泌尿生殖系感染及包涵体性结膜炎，二者血清型不同、传播途径各异。教材P75。

47. [A1型题 | 记忆] batch037-M3-A1-007

模块：M3 | 页码：教材P79

翼状胬肉在临床上最常见的发生部位是？

- **A. 鼻侧睑裂部球结膜** ✓
- B. 颞侧睑裂部球结膜
- C. 上方穹窿部结膜
- D. 下睑结膜
- E. 半月皱襞处结膜

答案：A

解析：翼状胬肉是向角膜表面生长、与结膜相连的纤维血管样组织，常发生于鼻侧睑裂区，多双眼发病，接近瞳孔区时可因散光或遮挡影响视力。教材P79。

48. [A1型题 | 理解] batch037-M3-A1-008

模块：M3 | 页码：教材P75

下列各项中，哪一项不属于沙眼晚期的常见后遗症？

- A. 睑内翻与倒睫
- B. 上睑下垂
- C. 睑球粘连
- D. 实质性结膜干燥症
- **E. 老年性白内障** ✓

答案：E

解析：沙眼晚期可发生睑内翻与倒睫、上睑下垂、睑球粘连、角膜混浊、实质性结膜干燥症及慢性泪囊炎；老年性白内障为晶状体混浊性疾病，与沙眼瘢痕机制无关。教材P75。

49. [A2型题 | 应用] batch037-M3-A2-001

模块：M3 | 页码：教材P71

患者男20岁，春秋季节双眼先后发红、异物感，晨起黏液脓性分泌物糊住睑缘而睁眼困难，视力一般不受影响。最可能的诊断是？

- A. 流行性角结膜炎
- **B. 急性卡他性结膜炎** ✓
- C. 春季角结膜炎
- D. 泡性角结膜炎
- E. 表层巩膜炎

答案：B

解析：急性或亚急性细菌性结膜炎又称急性卡他性结膜炎，俗称红眼病，潜伏期1~3天、双眼发病，黏液脓性分泌物晨起糊睑、较少累及角膜，符合本例；病毒性者多为水样分泌物伴耳前淋巴结肿大。教材P71。

50. [A2型题 | 应用] batch037-M3-A2-002

模块：M3 | 页码：教材P73

患儿男6岁，突发体温38.5℃、咽痛、双眼眼红流泪，睑结膜滤泡增生，耳前淋巴结肿大。最可能的诊断是？

- A. 急性卡他性结膜炎
- B. 淋球菌性结膜炎
- C. 春季角结膜炎
- **D. 咽结膜热** ✓
- E. 包涵体性结膜炎

答案：D

解析：咽结膜热由腺病毒3、4、7型引起，多见于4~9岁儿童，以急性滤泡性结膜炎、咽炎和发热三联征为特点，伴耳前淋巴结肿大，病程约10天有自限性。教材P73。

51. [A2型题 | 应用] batch037-M3-A2-003

对一名急性细菌性结膜炎患者，下列处理措施中错误的是？

- A. 分泌物多时用生理盐水冲洗结膜囊
- B. 急性阶段每1~2小时滴抗生素眼液
- C. 立即加压密闭包扎患眼 ☒
- D. 急性期注意隔离防止交叉感染
- E. 滴药前先清洁睑缘分泌物

答案：C

解析：细菌性结膜炎治疗强调祛除病因、局部敏感抗生素滴眼，分泌物多时可用3%硼酸水或生理盐水冲洗，但切勿包扎患眼（可戴太阳镜避光）；包扎易致局部温度升高、病原繁殖而加重感染。教材P72。

52. [A2型题 | 应用] batch037-M3-A2-004

患儿男12岁，每年春季双眼奇痒反复发作，上睑结膜见扁平巨大乳头呈铺路石样排列。最可能的诊断是？

- A. 春季角结膜炎 ☒
- B. 巨乳头性结膜炎
- C. 地方性流行性沙眼
- D. 泡性角结膜炎
- E. 季节性过敏性结膜炎（春季加重）

答案：A

解析：春季角结膜炎好发于青少年，季节性奇痒，睑结膜型以上睑结膜巨大乳头呈铺路石样为特征，可伴角膜缘Horner-Trantas结节；巨乳头性结膜炎多有接触镜或缝线机械诱因，季节性过敏性结膜炎一般无巨大乳头。教材P77。

53. [A2型题 | 理解] batch037-M3-A2-005

患者女10岁，角膜缘处见单发实性隆起红色小结节、周围局限性充血，轻微异物感，既往结核感染史。最可能的诊断是？

- A. 翼状胬肉

- B. 泡性角结膜炎 ☒
- C. 结膜结石
- D. 睑裂斑
- E. 球结膜下出血

答案：B

解析：泡性角结膜炎是微生物蛋白（如结核分枝杆菌蛋白）引起的迟发型免疫反应，多见于女性青少年儿童，表现为角膜缘或球结膜实性红色小结节伴周围充血，对局部糖皮质激素敏感。教材P78。

54. [A2型题 | 应用] batch037-M3-A2-006

模块：M3 | 页码：教材P81

患者男65岁，高血压病史，剧烈咳嗽后突发一眼球结膜片状鲜红色出血、边界清楚，视力不受影响。正确的处理是？

- A. 立即行结膜下手术止血
- B. 全身大剂量使用抗生素
- C. 立即加压包扎并绝对卧床
- D. 早期冷敷、2天后热敷并查找病因 ☒
- E. 长期局部使用糖皮质激素

答案：D

解析：球结膜下出血是症状而非独立病种，初期鲜红、7~12天自行吸收；处理首先寻找病因，出血早期局部冷敷、2天后改为热敷促进吸收，并做好解释消除顾虑。教材P81。

55. [A3型题 | 分析] batch037-M3-A3-001

模块：M3 | 页码：教材P75

患者女30岁，长期生活于卫生条件较差的农村，双眼慢性异物感、干涩，上穹窿及睑板上缘结膜污秽肥厚、乳头滤泡增生，并见垂帘状角膜血管翳，角膜缘滤泡发生瘢痕化。上述角膜缘滤泡瘢痕化改变在临床上称为？

- A. Arlt线
- B. Horner-Trantas结节
- C. Herbert小凹 ☒
- D. Stocker线
- E. 睑裂斑结节

答案：C

解析：角膜缘滤泡发生瘢痕化改变称为Herbert小凹，与垂帘状角膜血管翳、上睑结膜Arlt线瘢痕同为沙眼特有体征；Horner-Trantas结节见于春季角结膜炎，Stocker线为翼状胬肉头部色素沉积。教材P75。

56. [A4型题 | 理解] batch037-M3-A4-001

模块：M3 | 页码：教材P72

患者男25岁，有生殖器-眼接触史，单眼迅速出现结膜充血水肿伴大量脓性分泌物，24小时内加重，检查见周边角膜点状上皮混浊。确诊后最关键的用药原则是？

- A. 仅滴人工泪液并观察
- B. 局部冷敷不予用药
- C. 口服维生素增强营养
- D. 等待其自然痊愈
- E. 全身足量青霉素或头孢曲松钠 ☒

答案：E

解析：超急性淋球菌性结膜炎潜伏期短、进展迅猛，可迅速累及角膜甚至全身扩散，应在留取标本后立即局部联合全身用药：成人大剂量肌注青霉素或头孢曲松钠，角膜受累者加大剂量并延长疗程，青霉素过敏者用大观霉素。教材P72。

57. [B1型题 | 理解] batch037-M3-B1-001

模块：M3 | 页码：教材P73

引起流行性角结膜炎（EKC）的病原体是？

- A. 腺病毒8、19、29、37型 ☒
- B. 肠道病毒70型（EV70）
- C. 淋病奈瑟菌（淋球菌）
- D. 沙眼衣原体A、B、Ba、C型
- E. 流感嗜血杆菌性结膜炎

答案：A

解析：流行性角结膜炎由腺病毒8、19、29和37型（人腺病毒D亚组）引起，潜伏期5~7天，以急性滤泡性结膜炎伴晚期角膜上皮浸润、耳前淋巴结肿大为特征。教材P73。

58. [B1型题 | 理解] batch037-M3-B1-002

模块：M3 | 页码：教材P75

地方性流行的结膜炎，其病原体是？

- A. 腺病毒8、19、29、37型
- B. 肠道病毒70型（EV70）
- C. 淋病奈瑟菌（淋球菌）
- D. 沙眼衣原体A、B、Ba、C型 ☒
- E. 流感嗜血杆菌性结膜炎

答案：D

解析：地方性流行性沙眼由沙眼衣原体A、B、Ba、C抗原型引起；D~K型主要致生殖泌尿系感染及包涵体性结膜炎，二者血清型与传播方式不同，应注意鉴别。教材P75。

59. [X型题 | 理解] batch037-M3-X-001

模块：M3 | 页码：教材P69

下列各项中，属于结膜炎重要常见体征的有？

- A. 结膜充血水肿 ☒
- B. 乳头增生与滤泡形成 ☒
- C. 结膜下出血 ☒
- D. 真膜或假膜形成 ☒
- E. 虹膜后粘连

答案：ABCD

解析：结膜炎重要体征包括结膜充血、水肿、渗出物、乳头增生、滤泡、结膜下出血、真膜和假膜、耳前淋巴结肿大等；虹膜后粘连是前葡萄膜炎的体征，提示虹膜炎而非结膜病变。教材P69。

60. [判断题 | 理解] batch037-M3-判断-001

模块：M3 | 页码：教材P81

球结膜下出血多提示存在严重全身出血性疾病，须立即全身大剂量使用止血药物治疗。

- A. 正确
- B. 错误 ☒

答案：B

解析：严格说球结膜下出血是症状而非独立病种，极少能找到确切病因，多可7~12天自行吸收；处理为寻找病因、早期冷敷2天后热敷，无需立即全身大剂量止血药，反复发作才需系统检查。教材P81。

M4（20题）

61. [A1型题 | 记忆] batch037-M4-A1-001

模块：M4 | 页码：教材P82

角膜从前到后的五层结构依次是？

- A. 上皮、前弹力层、基质、后弹力层、内皮 ☒
- B. 上皮、基质、前弹力层、后弹力层、内皮
- C. 前弹力层、上皮、基质、后弹力层、内皮
- D. 上皮、前弹力层、后弹力层、基质、内皮
- E. 上皮、基质、后弹力层、前弹力层、内皮

答案：A

解析：角膜从前到后分为上皮层、前弹力层（Bowman膜）、基质层、后弹力层（Descemet膜）和内皮层共5层，上皮表面还覆盖泪膜。教材P82。

62. [A1型题 | 理解] batch037-M4-A1-002

模块：M4 | 页码：教材P83

关于角膜各层损伤后的修复，正确的是？

- A. 上皮层损伤后不能再生修复
- B. 前弹力层损伤后可再生
- C. 后弹力层损伤后不能再生
- D. 内皮层在体可分裂再生
- E. 基质层损伤后由瘢痕修复 ☒

答案：E

解析：上皮层损伤后可再生不留瘢痕；前弹力层受损不能再生；基质层损伤后由瘢痕组织修复而失去透明性；后弹力层可由内皮细胞分泌再生；在体状态下角膜内皮细胞不能再生。教材P83。

63. [A1型题 | 记忆] batch037-M4-A1-003

模块：M4 | 页码：教材P85

铜绿假单胞菌性角膜溃疡的典型分泌物特点是？

- A. 水样浆液性分泌物
- **B. 大量黏稠脓性略带黄绿色** ✓
- C. 黏丝状白色分泌物
- D. 淡红色血性分泌物
- E. 油脂样黄色分泌物

答案：B

解析：铜绿假单胞菌所致角膜炎起病急骤、发展迅猛，溃疡表面有大量黏稠脓性分泌物、略带黄绿色，溃疡周围可见黄白色浸润环，伴大量前房积脓。教材P85。

64. [A1型题 | 理解] batch037-M4-A1-004

模块：M4 | 页码：教材P87

丝状真菌性角膜炎最主要的诱因是？

- A. 长期戴用角膜接触镜
- B. 慢性泪囊炎长期刺激
- **C. 植物性角膜外伤** ✓
- D. 糖尿病全身感染
- E. 紫外线过度照射

答案：C

解析：丝状真菌（镰孢菌、曲霉菌、弯孢菌）引起的角膜感染多见于农业或户外工作人群，植物性外伤（树枝、甘蔗叶、稻草等）是最主要的诱因。教材P87。

65. [A1型题 | 记忆] batch037-M4-A1-005

模块：M4 | 页码：教材P89

上皮型单纯疱疹病毒性角膜炎的典型体征是？

- A. 圆形局灶性脓肿
- B. 牙膏样乳白色病灶
- C. 环形角膜浸润

- D. 树枝状角膜溃疡 ☒
- E. 盘状基质水肿

答案：D

解析：上皮型HSV感染后上皮细胞坏死崩解并融合，形成树枝状溃疡，树枝末端可见分叉和结节状膨大，荧光素染色中央深绿、边缘淡绿，伴角膜知觉减退。教材P89。

66. [A1型题 | 理解] batch037-M4-A1-006

模块：M4 | 页码：教材P83

角膜浅层瘢痕薄如云雾状，通过混浊部分仍能透见虹膜纹理者称为？

- A. 角膜斑翳
- B. 角膜云翳 ☒
- C. 角膜白斑
- D. 角膜葡萄肿
- E. 角膜脂质变性

答案：B

解析：浅层瘢痕薄如云雾状、仍能透见虹膜纹理者为角膜云翳；混浊较厚略白仍可透见虹膜为斑翳；瓷白色不能透见虹膜为白斑。教材P83。

67. [A1型题 | 记忆] batch037-M4-A1-007

模块：M4 | 页码：教材P95

角膜老年环的病理改变部位是？

- A. 角膜中央前弹力层钙化
- B. 角膜内皮面滴状赘疣
- C. 角膜上皮下囊肿形成
- D. 角膜周边部基质类脂质沉着 ☒
- E. 角膜深层新生血管长入

答案：D

解析：角膜老年环是角膜周边部基质内的类脂质沉着，呈约1mm宽白色环，外侧边界清楚、内侧稍模糊，与角膜缘之间有透明角膜带相隔；50-60岁约60%存在。教材P95。

68. [A1型题 | 理解] batch037-M4-A1-008

模块：M4 | 页码：教材P86

关于细菌性角膜炎的治疗，错误的是？

- A. 高浓度抗生素眼药水频繁滴眼
- B. 革兰阳性球菌首选头孢唑林
- C. 革兰阴性杆菌首选妥布霉素
- D. 并发虹睫炎用阿托品散瞳
- E. 急性期常规全身使用糖皮质激素 ☒

答案：E

解析：细菌性角膜炎急性期应以高浓度抗生素频繁滴眼控制感染；长期局部使用皮质类固醇激素本身是诱发因素之一，不应常规全身使用激素；并发虹膜睫状体炎时用1%阿托品散瞳。教材P86。

69. [A2型题 | 应用] batch037-M4-A2-001

模块：M4 | 页码：教材P85

男20岁，戴隐形眼镜过夜后右眼剧痛畏光1天，混合充血，角膜中央溃疡表面大量黄绿色黏稠脓性分泌物，周围见黄白色浸润环，前房大量积脓。最可能的诊断是？

- A. 真菌性角膜溃疡
- B. 单疱病毒性角膜炎
- C. 铜绿假单胞菌性角膜炎 ☒
- D. 棘阿米巴性角膜炎
- E. 肺炎链球菌性角膜炎

答案：C

解析：戴角膜接触镜后急性起病、剧烈眼痛、角膜基质广泛液化性坏死伴黄绿色黏稠脓性分泌物和前房积脓，是铜绿假单胞菌性角膜炎的典型表现。教材P85。

70. [A2型题 | 应用] batch037-M4-A2-002

模块：M4 | 页码：教材P87

农忙时左眼被稻草划伤后2周，刺激症状较轻，角膜中央乳白色致密病灶表面呈牙膏样，旁见伪足及卫星灶，前房灰白色黏稠积脓。最可能的诊断是？

- A. 细菌性角膜溃疡
- **B. 真菌性角膜溃疡** ☒
- C. 单疱病毒性角膜炎
- D. 蚕蚀性角膜溃疡
- E. 角膜基质炎

答案：B

解析：植物外伤史+起病缓慢+牙膏样乳白色致密病灶+伪足/卫星灶+灰白色黏稠糊状前房积脓，是真菌性角膜溃疡的典型特征。教材P87。

71. [A2型题 | 应用] batch037-M4-A2-003

模块：M4 | 页码：教材P89

女28岁，反复右眼畏光流泪2年，近日感冒后复发，裂隙灯下见角膜中央树枝状上皮缺损，荧光素染色中央深绿、边缘淡绿，病灶区角膜知觉减退。最可能的诊断是？

- A. 真菌性角膜溃疡
- B. 铜绿假单胞菌性角膜炎
- C. 浅层点状上皮性角膜炎
- D. 棘阿米巴性角膜炎
- **E. 上皮型单纯疱疹病毒性角膜炎** ☒

答案：E

解析：反复发作、感冒后诱发、树枝状上皮缺损伴荧光素染色特征及角膜知觉减退，是复发性上皮型单纯疱疹病毒性角膜炎的典型表现。教材P89。

72. [A2型题 | 应用] batch037-M4-A2-004

模块：M4 | 页码：教材P87

患者细菌性角膜溃疡，病灶处角膜进行性变薄，后弹力层在眼压作用下呈透明水珠状膨出。最恰当的处理是？

- A. 局部热敷促进血管长入
- B. 立即全身大剂量使用激素
- C. 角膜加压包扎并长期观察
- **D. 积极抗感染并准备角膜移植** ☒
- E. 自行穿孔后再行处理

答案：D

解析：后弹力层膨出提示溃疡濒临穿孔，应在强化局部抗感染基础上酌情行结膜瓣遮盖或角膜移植术，等待自行穿孔会导致眼内感染、眼球萎缩。教材P87。

73. [A2型题 | 理解] batch037-M4-A2-005

模块：M4 | 页码：教材P88

确诊真菌性角膜溃疡的患者，治疗中不宜采用的措施是？

- A. 频繁滴用那他霉素
- **B. 局部使用糖皮质激素** ✓
- C. 口服氟康唑全身用药
- D. 1%阿托品散瞳
- E. 药物无效时板层移植

答案：B

解析：真菌性角膜炎并发虹膜睫状体炎时用阿托品散瞳，但不宜使用糖皮质激素；一线抗真菌药为5%那他霉素和0.15%两性霉素B，严重者联合全身抗真菌药。教材P88。

74. [A2型题 | 记忆] batch037-M4-A2-006

模块：M4 | 页码：教材P101

按《中国干眼专家共识（2020年）》，无麻醉下Schirmer I 试验诊断干眼的推荐界值是？

- A. $\leq 2\text{mm}/5\text{min}$
- B. $\leq 5\text{mm}/5\text{min}$
- **C. $\leq 10\text{mm}/5\text{min}$** ✓
- D. $\leq 15\text{mm}/5\text{min}$
- E. $\leq 20\text{mm}/5\text{min}$

答案：C

解析：《中国干眼专家共识（2020年）》推荐无麻醉Schirmer I 试验 $\leq 10\text{mm}/5\text{min}$ 为泪液分泌减少的诊断界值；结合症状和BUT可进一步诊断干眼。教材P101。

75. [A3型题 | 应用] batch037-M4-A3-001

男22岁，戴软性角膜接触镜5年，游泳后次日右眼剧痛、畏光、流泪，视力骤降。查体：眼睑及球结膜水肿，混合充血，角膜中央偏下溃疡，表面大量黄绿色黏稠脓性分泌物，周围见黄白色浸润环，前房大量积脓。该患者最关键的初始治疗措施是？

- A. 全身大剂量糖皮质激素冲击
- B. 等待培养结果后再用药
- C. 局部热敷促进血液循环
- **D. 立即高浓度抗生素频繁滴眼** ✓
- E. 行角膜移植关闭病灶

答案：D

解析：疑似铜绿假单胞菌性角膜炎病情危重、进展迅猛，应立即给予强化局部抗生素治疗（高浓度抗生素频繁滴眼），不必等待培养结果；可先广谱联合用药，再依细菌培养和药敏调整。教材P86。

76. [A4型题 | 分析] batch037-M4-A4-001

男30岁，右眼反复红肿疼痛2年，此次感冒后加重。查体：角膜中央树枝状上皮缺损，荧光素染色阳性，病灶区知觉减退；同时角膜中央基质水肿混浊，内皮面可见KP。经局部抗病毒治疗1周后树枝状溃疡已愈合，但基质水肿仍明显、虹膜炎体征突出。关于该患者下一步治疗，错误的是？

- A. 加用局部糖皮质激素抗炎
- B. 继续口服抗病毒药减少复发
- **C. 立即停用一切抗病毒药物** ✓
- D. 用1%阿托品散瞳防止粘连
- E. 愈合后瘢痕影响视力考虑移植

答案：C

解析：患者上皮型已愈合、进入基质型/内皮型阶段，发病以免疫性炎症为主，应在继续抗病毒基础上加用局部激素抗炎，并口服阿昔洛韦预防复发；立即停用抗病毒药物可致病毒再活化、病情反复。教材P91。

77. [B1型题 | 记忆] batch037-M4-B1-001

角膜浅层瘢痕薄如云雾状，通过混浊部分仍能看清后面虹膜纹理者是？

- A. 角膜云翳 ☒
- B. 角膜斑翳
- C. 角膜白斑
- D. 角膜葡萄肿
- E. 角膜瘘

答案：A

解析：浅层瘢痕薄如云雾状、仍能透见虹膜纹理者为角膜云翳；混浊较厚略白仍可透见虹膜为斑翳；瓷白色不能透见虹膜为白斑。教材P83。

78. [B1型题 | 理解] batch037-M4-B1-002

模块：M4 | 页码：教材P83

角膜溃疡愈合后遗留很厚的瓷白色瘢痕，完全不能透见虹膜纹理者是？

- A. 角膜云翳
- B. 角膜斑翳
- C. 角膜白斑 ☒
- D. 角膜葡萄肿
- E. 角膜瘘

答案：C

解析：混浊很厚呈瓷白色、不能透见虹膜纹理者为角膜白斑；若瘢痕中嵌有虹膜组织则为粘连性角膜白斑，提示有穿孔史。教材P83。

79. [X型题 | 理解] batch037-M4-X-001

模块：M4 | 页码：教材P82

维持角膜透明性的因素包括？

- A. 角膜无血管 ☒
- B. 基质胶原纤维规则排列 ☒
- C. 上皮与泪膜完整光滑 ☒
- D. 内皮细胞Na⁺-K⁺泵功能 ☒
- E. 角膜缘血管网供血丰富

答案：ABCD

解析：角膜透明由完整上皮与泪膜形成光滑光学界面、基质胶原纤维规则网格排列减少光散射、角膜无血管以及内皮细胞能量依赖性Na⁺-K⁺泵维持基质半脱水状态共同维持；角膜缘血管网供血不属于中央角膜透明因素。教材P82。

80. [判断题 | 理解] batch037-M4-判断-001

模块：M4 | 页码：教材P83

在体状态下角膜内皮细胞受损伤后不能再生，仅靠毗邻细胞移行、增大和迁徙覆盖损伤区。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

答案：A

解析：在体状态下角膜内皮细胞不能再生，损伤后毗邻细胞通过移行、增大和迁徙覆盖损伤区重建完整内皮单层；若内皮损伤严重，则出现不可逆角膜水肿。教材P83。

M5 (20题)

81. [A1型题 | 记忆] batch037-M5-A1-001

模块：M5 | 页码：教材P106

按解剖位置分类，葡萄膜炎可分为？

- A. 急、亚急、慢及复发性葡萄膜炎
- B. 肉芽肿性与非肉芽肿性葡萄膜炎
- C. 前、中间、后及全葡萄膜炎 ☒
- D. 感染性与非感染性葡萄膜炎
- E. 轻、中、重度葡萄膜炎

答案：C

解析：国际葡萄膜炎研究组按解剖位置将葡萄膜炎分为前葡萄膜炎、中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎四类；肉芽肿性/非肉芽肿性属临床病理分类，感染性/非感染性属病因分类。教材P106。

82. [A1型题 | 理解] batch037-M5-A1-002

模块：M5 | 页码：教材P106

羊脂状角膜后沉着物（KP）主要见于？

- A. 急性结膜炎
- **B. 肉芽肿性葡萄膜炎** ✓
- C. 急性闭角型青光眼
- D. 春季角结膜炎
- E. 电光性眼炎

答案：B

解析：羊脂状KP主要由单核巨噬细胞和类上皮细胞构成，见于肉芽肿性葡萄膜炎；尘状KP主要见于非肉芽肿性前葡萄膜炎，中等大小KP见于Fuchs综合征、青光眼睫状体炎综合征等。教材P106。

83. [A1型题 | 记忆] batch037-M5-A1-003

模块：M5 | 页码：教材P106

我国葡萄膜炎中最常见的类型是？

- A. 中间葡萄膜炎
- B. 后葡萄膜炎
- C. 全葡萄膜炎
- **D. 前葡萄膜炎** ✓
- E. 交感性眼炎

答案：D

解析：前葡萄膜炎包括虹膜炎、虹膜睫状体炎和前部睫状体炎，是葡萄膜炎中最常见的类型，约占我国葡萄膜炎总数的50%。教材P106。

84. [A1型题 | 理解] batch037-M5-A1-004

模块：M5 | 页码：教材P109

治疗急性前葡萄膜炎、防止和拉开新鲜虹膜后粘连的必需药物是？

- A. 缩瞳剂
- B. 降眼压药
- C. 抗生素滴眼液
- D. 抗病毒药
- **E. 睫状肌麻痹剂** ✓

答案：E

解析：睫状肌麻痹剂是治疗急性前葡萄膜炎的必需药物，可防止和拉开虹膜后粘连、解除睫状肌与瞳孔括约肌痉挛，最常用后马托品眼膏。教材P109。

85. [A1型题 | 记忆] batch037-M5-A1-005

模块：M5 | 页码：教材P110

中间葡萄膜炎的特征性体征是？

- A. 角膜后羊脂状KP沉着
- B. 眼底晚霞状改变（VKH）
- C. 睫状体扁平部雪堤样改变 ✓
- D. 视网膜动脉拇指印坏死
- E. 视盘水肿及充血

答案：C

解析：睫状体扁平部雪堤样（snowbank）改变是中间葡萄膜炎的特征性改变，为伸向玻璃体中央的舌形病灶；玻璃体雪球状混浊亦常见。教材P110。

86. [A1型题 | 记忆] batch037-M5-A1-006

模块：M5 | 页码：教材P112

Vogt-小柳原田病（VKH）的典型临床特征是？

- A. 单眼急性非肉芽肿性前葡萄膜炎
- B. 双眼肉芽肿性全葡萄膜炎伴白癜风脱发 ✓
- C. 复发性口腔溃疡伴生殖器溃疡
- D. 单眼虹膜脱色素无后粘连
- E. 周边视网膜动脉坏死灶

答案：B

解析：VKH是以双侧肉芽肿性全葡萄膜炎为特征的疾病，常伴脑膜刺激征、听力障碍、白癜风、毛发变白或脱发，又称特发性葡萄膜大脑炎。教材P112。

87. [A1型题 | 理解] batch037-M5-A1-007

下列哪项不属于Behçet病的典型临床表现？

- A. 复发性口腔溃疡
- B. 疼痛性生殖器溃疡
- C. 结节性红斑等皮肤损害
- **D. 复发性肉芽肿性前葡萄膜炎** ✓
- E. 皮肤针刺反应阳性

答案：D

解析：Behçet病眼部损害多为反复发作的全葡萄膜炎，呈非肉芽肿性，约25%出现前房积脓；肉芽肿性前葡萄膜炎不是其典型表现。教材P113。

88. [A1型题 | 理解] batch037-M5-A1-008

模块：M5 | 页码：教材P108

下列哪项不是前葡萄膜炎的常见并发症？

- **A. 视网膜母细胞瘤** ✓
- B. 继发性白内障
- C. 继发性青光眼
- D. 持续性低眼压
- E. 眼球萎缩变小

答案：A

解析：前葡萄膜炎常见并发症包括继发性白内障（后囊下混浊）、继发性青光眼及低眼压与眼球萎缩；视网膜母细胞瘤为儿童眼内恶性肿瘤，与炎症无关。教材P108。

89. [A2型题 | 应用] batch037-M5-A2-001

模块：M5 | 页码：教材P108

患者男，25岁，突发左眼眼痛、畏光、流泪1天。查视力0.4，睫状充血，角膜后尘状KP，前房闪辉明显，瞳孔缩小。最可能的诊断是？

- A. 急性卡他性结膜炎
- **B. 急性前葡萄膜炎** ✓
- C. 急性闭角型青光眼
- D. 细菌性角膜炎

- E. 眼睑急性睑腺炎

答案：B

解析：突发眼痛、畏光、流泪伴睫状充血、尘状KP、前房闪辉、瞳孔缩小，是急性前葡萄膜炎（虹膜睫状体炎）的典型表现；急性闭角型青光眼瞳孔散大、角膜雾浊。教材P108。

90. [A2型题 | 理解] batch037-M5-A2-002

模块：M5 | 页码：教材P109

患者急性眼痛伴视力骤降，检查见角膜上皮水肿、角膜雾状混浊、前房浅、瞳孔椭圆形散大、眼压升高，无前房炎症细胞。最可能的诊断是？

- A. 急性前葡萄膜炎
- B. 急性卡他性结膜炎
- C. 急性闭角型青光眼 ☒
- D. 感染性角膜炎
- E. 眶蜂窝织炎

答案：C

解析：急性闭角型青光眼表现为视力骤降、头痛恶心呕吐、角膜雾浊、前房浅、瞳孔椭圆散大、眼压高，无前房炎症细胞；与前葡萄膜炎的瞳孔缩小、KP、大量前房细胞鉴别。教材P109。

91. [A2型题 | 应用] batch037-M5-A2-003

模块：M5 | 页码：教材P113

患者男，30岁，反复口腔溃疡3年，近1年双眼反复红痛、视力下降，伴疼痛性生殖器溃疡及下肢结节红斑。最可能的诊断是？

- A. Vogt-小柳原田病
- B. 交感性眼炎
- C. Fuchs综合征
- D. Behçet病 ☒
- E. 强直性脊柱炎

答案：D

解析：复发性口腔溃疡、生殖器溃疡、皮肤损害（结节红斑）和反复发作的全葡萄膜炎是Behçet病四大主征，针刺反应阳性为其特征性皮肤改变。教材P113。

92. [A2型题 | 应用] batch037-M5-A2-004

模块：M5 | 页码：教材P112

患者女，35岁，2周前头痛、耳鸣、听力下降，随后双眼视力下降；检查见双眼弥漫性脉络膜炎、渗出性视网膜脱离，伴白发及白癜风。最可能的诊断是？

- A. Vogt-小柳原田病 ☒
- B. Behçet病
- C. 交感性眼炎
- D. Fuchs综合征
- E. 急性视网膜坏死

答案：A

解析：前驱期脑膜刺激征、耳鸣听力下降，随后双侧弥漫性脉络膜炎、渗出性视网膜脱离，后期出现晚霞状眼底、白癜风、毛发变白，为VKH典型病程；无眼外伤史可与交感性眼炎鉴别。教材P112。

93. [A2型题 | 理解] batch037-M5-A2-005

模块：M5 | 页码：教材P113

患者男，28岁，右眼穿通伤缝合术后1个月，左眼出现畏光、视力下降；检查见双侧肉芽肿性葡萄膜炎，右眼为受伤眼。最可能的诊断是？

- A. Vogt-小柳原田病
- B. Behçet病
- C. Fuchs综合征
- D. 中间葡萄膜炎
- E. 交感性眼炎 ☒

答案：E

解析：一眼穿通伤或内眼手术后双侧肉芽肿性葡萄膜炎，受伤眼为诱发眼、另一眼为交感眼，即交感性眼炎；外伤史是与VKH鉴别的关键依据。教材P113。

94. [A2型题 | 应用] batch037-M5-A2-006

模块：M5 | 页码：教材P114

患者女，40岁，右眼视物模糊2年，无明显眼痛。检查见右眼虹膜弥漫性脱色素、角膜后中等大小KP弥漫分布、前房轻度闪辉、无虹膜后粘连。最可能的诊断是？

- A. 急性前葡萄膜炎
- B. 中间葡萄膜炎
- C. Fuchs葡萄膜炎综合征 ☒
- D. Vogt-小柳原田病
- E. Behçet病

答案：C

解析：Fuchs综合征以虹膜弥漫性脱色素为特征的慢性非肉芽肿性葡萄膜炎，90%单眼受累，典型中等大小KP弥漫分布，无虹膜后粘连；易并发后囊下白内障和眼压升高。教材P114。

95. [A3型题 | 应用] batch037-M5-A3-001

模块：M5 | 页码：教材P109

患者男，22岁，反复腰骶部疼痛2年，晨起明显、活动后减轻。3天前突发双眼交替性红痛、畏光。查HLA-B27阳性，角膜后尘状KP，前房大量炎症细胞，瞳孔缩小。该眼前段炎症的首选局部治疗是？

- A. 缩瞳剂联合降眼压药
- B. 睫状肌麻痹剂联合糖皮质激素滴眼液 ☒
- C. 抗病毒药联合缩瞳剂
- D. 抗生素联合散瞳剂
- E. 抗VEGF眼内注射

答案：B

解析：强直性脊柱炎20%~25%并发急性非肉芽肿性前葡萄膜炎，治疗原则为立即睫状肌麻痹剂散瞳防止后粘连，并迅速局部糖皮质激素抗炎；绝大多数非感染性不需抗生素。教材P109、P111。

96. [A4型题 | 分析] batch037-M5-A4-001

模块：M5 | 页码：教材P113

患者男，28岁，Behçet病反复发作5年，近1个月右眼视力骤降。检查见右眼视网膜炎、视网膜血管闭塞、前房积脓，既往口服泼尼松30mg/d仅短期缓解。下一步最合理的治疗是？

- A. 长期大剂量口服糖皮质激素维持

- B. 单纯加用抗生素治疗
- C. 立即行白内障摘除手术
- **D. 糖皮质激素联合环孢素等免疫抑制剂** ✓
- E. 单纯睫状肌麻痹剂点眼

答案：D

解析：Behçet病不宜长期大剂量使用糖皮质激素，出现严重视网膜炎/视网膜血管炎时需短期大剂量激素联合环孢素等免疫抑制剂，顽固性病例可加用抗肿瘤坏死因子生物制剂。教材P113。

97. [B1型题 | 理解] batch037-M5-B1-001

模块：M5 | 页码：教材P106

肉芽肿性葡萄膜炎常见的角膜后沉着物（KP）是？

- A. 尘状KP
- B. 中等大小KP
- **C. 羊脂状KP** ✓
- D. 雪堤样改变
- E. 晚霞状眼底改变

答案：C

解析：羊脂状KP由单核巨噬细胞和类上皮细胞构成，主要见于肉芽肿性葡萄膜炎；尘状KP多见于非肉芽肿性前葡萄膜炎。教材P106。

98. [B1型题 | 记忆] batch037-M5-B1-002

模块：M5 | 页码：教材P110

中间葡萄膜炎在睫状体扁平部的特征性改变是？

- A. 尘状KP
- B. 中等大小KP
- C. 羊脂状KP
- **D. 雪堤样改变** ✓
- E. 晚霞状眼底改变

答案：D

解析：雪堤样改变是中间葡萄膜炎的特征性体征，指发生于睫状体扁平部并伸向玻璃体中央的舌形病灶，多见于下方；玻璃体雪球状混浊亦常见。教材P110。

99. [X型题 | 理解] batch037-M5-X-001

模块：M5 | 页码：教材P108

前葡萄膜炎反复发作或慢性化可引起下列哪些并发症？

- A. 并发性白内障 ☒
- B. 继发性青光眼 ☒
- C. 低眼压及眼球萎缩 ☒
- D. 视网膜母细胞瘤
- E. 脉络膜黑色素瘤

答案：ABC

解析：前葡萄膜炎三大并发症为并发性白内障（后囊下混浊）、继发性青光眼（炎症阻塞小梁网或瞳孔闭锁）及低眼压与眼球萎缩（睫状体脱离或萎缩）；后两者为眼内肿瘤，非炎症并发症。教材P108。

100. [判断题 | 记忆] batch037-M5-判断-001

模块：M5 | 页码：教材P107

前房闪辉是反映眼前段活动性炎症的最可靠指标。

- A. 正确
- B. 错误 ☒

答案：B

解析：前房闪辉由血-房水屏障破坏、蛋白进入房水所致，炎症消退后仍可持续存在，不一定代表活动性炎症；前房炎症细胞才是反映眼前段炎症的可靠指标。教材P107。

M6 (20题)

101. [A1型题 | 记忆] batch037-M6-A1-001

模块：M6 | 页码：教材P116

晶状体为无血管的透明组织，其营养主要来源于？

- A. 角膜和泪膜
- B. 虹膜和睫状体
- **C. 房水和玻璃体** ✓
- D. 视网膜和脉络膜
- E. 巩膜和结膜

答案：C

解析：晶状体无血管，营养主要来源于房水和玻璃体，并通过代谢维持透明性与调节功能；其余选项均非晶状体供血供氧的主要途径。教材P116。

102. [A1型题 | 记忆] batch037-M6-A1-002

模块：M6 | 页码：教材P116

白内障的本质是？

- A. 玻璃体发生液化后脱离
- B. 角膜上皮云翳形成
- C. 房水排出通路受阻
- **D. 晶状体透明度降低或颜色改变** ✓
- E. 视网膜感光细胞变性

答案：D

解析：白内障是指晶状体透明度降低或颜色改变所导致的光学质量下降的退行性改变，属晶状体本身病变，而非角膜、房水或视网膜病变。教材P116。

103. [A1型题 | 记忆] batch037-M6-A1-003

模块：M6 | 页码：教材P116

临床上最为常见的白内障类型是？

- A. 先天性白内障
- **B. 年龄相关性白内障** ✓
- C. 外伤性白内障
- D. 代谢性白内障
- E. 并发性白内障

答案：B

解析：年龄相关性白内障又称老年性白内障，多见于50岁以上，是最常见的白内障类型，随年龄增长发病率明显升高。教材P116。

104. [A1型题 | 理解] batch037-M6-A1-004

模块：M6 | 页码：教材P117

皮质性白内障初期，晶状体周边皮质典型的混浊形态是？

- A. 楔形混浊 ☒
- B. 点状混浊
- C. 盘状混浊
- D. 缝状混浊
- E. 膜状混浊

答案：A

解析：初期在周边前后皮质形成楔形、呈羽毛状、尖端指向中央的混浊，可在赤道部汇合成轮辐状，散瞳后红光反射见轮辐状阴影。教材P117。

105. [A1型题 | 理解] batch037-M6-A1-005

模块：M6 | 页码：教材P117

皮质性白内障膨胀期（未成熟期）的特征性体征是？

- A. 虹膜震颤
- B. 虹膜后粘连
- C. 虹膜投影 ☒
- D. 虹膜节段萎缩
- E. 虹膜新生血管

答案：C

解析：膨胀期皮质吸水肿胀、前房变浅，斜照法时投照侧虹膜在深层混浊皮质上形成新月形阴影，即虹膜投影，为此期特点；此期可诱发闭角型青光眼急性发作。教材P117。

106. [A1型题 | 理解] batch037-M6-A1-006

模块：M6 | 页码：教材P117

Morgagnian 白内障是指过熟期出现的哪种表现？

- **A. 棕黄色核沉于囊袋下方** ✓
- B. 皮质吸水晶状体体积增大
- C. 新月形虹膜投影形成
- D. 前房深度恢复正常
- E. 晶状体完全呈乳白色

答案：A

解析：过熟期晶状体纤维分解液化呈乳白色，棕黄色核沉于囊袋下方并随体位移动，称 Morgagnian 白内障；核下沉后视力可突然提高。B、C 属膨胀期，D、E 属成熟期。教材 P117。

107. [A1型题 | 记忆] batch037-M6-A1-007

模块：M6 | 页码：教材P122

明显影响视力的单眼先天性白内障，全身及麻醉情况允许时建议在何时手术？

- A. 出生后1~2天
- **B. 出生后4~6周** ✓
- C. 出生后6~12个月
- D. 出生后2~3岁
- E. 出生后5~6岁

答案：B

解析：明显影响视力的单眼先天性白内障，在全身及麻醉许可下建议出生后4~6周行晶状体摘除，以尽早获得有效视觉刺激、防止弱视形成。教材P122。

108. [A1型题 | 理解] batch037-M6-A1-008

模块：M6 | 页码：教材P125

关于后发性白内障（后囊膜混浊，PCO）的处理，错误的是？

- A. 影响视力时首选Nd:YAG激光切开后囊
- B. 后囊混浊过厚可手术剪开后囊
- C. 术后滴糖皮质激素预防炎症
- **D. 一经发现即行角膜移植** ✓
- E. 治疗后需注意监测眼压变化

答案：D

解析：PCO影响视力时首选Nd:YAG激光后囊切开，无法激光或过厚时可手术刺开/剪开，并滴用抗炎眼药、观察眼压；PCO是后囊膜混浊，与角膜无关，无需角膜移植。教材P125。

109. [A2型题 | 应用] batch037-M6-A2-001

模块：M6 | 页码：教材P117

女，68岁，双眼渐进性视力下降2年。裂隙灯见晶状体灰白色混浊，斜照法时投照侧虹膜在深层混浊皮质上形成新月形阴影。其皮质性白内障分期最可能是？

- A. 皮质性初发期
- B. 皮质性成熟期
- C. 皮质性膨胀期 ☒
- D. 皮质性过熟期
- E. 核性白内障期

答案：C

解析：斜照法出现新月形虹膜投影是膨胀期（未成熟期）的特征，此期皮质吸水肿胀、前房变浅；初发期仅见楔形混浊，成熟期呈乳白色完全混浊，过熟期囊膜皱缩、核下沉。教材P117。

110. [A2型题 | 应用] batch037-M6-A2-002

模块：M6 | 页码：教材P118

男，70岁，远视力缓慢下降，近年老视减轻、近视度数加深。裂隙灯见晶状体核呈黄褐色。最可能的诊断是？

- A. 皮质性白内障
- B. 后囊下白内障
- C. 先天性白内障
- D. 核性白内障 ☒
- E. 代谢性白内障

答案：D

解析：核性白内障发病较早、进展缓慢，核屈光力增强致晶状体性近视、老视减轻，核颜色由黄色渐呈黄褐色乃至棕色；与皮质性、后囊下及代谢性白内障的混浊部位不同。教材P118。

111. [A2型题 | 应用] batch037-M6-A2-003

模块：M6 | 页码：教材P123

女，19岁，1型糖尿病8年，近1个月双眼视力骤降至手动，晶状体在短时间内迅速完全混浊。最可能的诊断是？

- A. 糖尿病患者的年龄相关性白内障
- **B. 真性糖尿病性白内障** ✓
- C. 先天性绕核性白内障
- D. 半乳糖性白内障
- E. 低钙性白内障

答案：B

解析：真性糖尿病性白内障多见于青少年1型糖尿病，双眼发病、发展迅速，可短时间内全白内障；其机制为血糖升高激活醛糖还原酶使山梨醇积聚、渗透压增高致纤维肿胀。教材P123。

112. [A2型题 | 理解] batch037-M6-A2-004

模块：M6 | 页码：教材P117

过熟期白内障可引起多种并发症，除外？

- A. 晶状体蛋白诱发葡萄膜炎
- B. 晶状体溶解性青光眼
- C. 晶状体脱位继发青光眼
- **D. 孔源性视网膜脱离** ✓
- E. 晶状体过敏性炎症反应

答案：D

解析：过熟期液化皮质渗漏可致晶状体蛋白（过敏性）葡萄膜炎，皮质沉积或被巨噬细胞堵塞房角引起晶状体溶解性青光眼，悬韧带变性致脱位还可继发青光眼；孔源性视网膜脱离并非其并发症。教材P117。

113. [A2型题 | 应用] batch037-M6-A2-005

模块：M6 | 页码：教材P125

男，72岁，白内障超声乳化联合人工晶状体植入术后3年，视力再次逐渐下降。裂隙灯见后囊膜厚薄不均机化组织及Elschnig珠样小体。首选处理是？

- A. 再次行玻璃体切割
- B. 立即取出人工晶状体
- C. Nd:YAG激光后囊切开 ☒
- D. 角膜移植手术
- E. 长期全身用激素

答案：C

解析：囊外摘除术后残留上皮增生形成Elschnig珠、后囊膜混浊即PCO，为术后最常见并发症；影响视力时首选Nd:YAG激光将瞳孔区后囊膜切开，无需取IOL或角膜移植。教材P125。

114. [A2型题 | 理解] batch037-M6-A2-006

模块：M6 | 页码：教材P124

并发性白内障由眼部疾病所致，其常见病因不包括？

- A. 葡萄膜炎
- B. 视网膜色素变性
- C. 原发性视网膜脱离
- D. 高度近视
- E. 老年性年龄变化 ☒

答案：E

解析：并发性白内障常见于葡萄膜炎、视网膜色素变性、视网膜脱离、青光眼、眼内肿瘤及高度近视等眼部病变；老年性年龄变化本身属年龄相关性白内障，并非并发症。教材P124。

115. [A3型题 | 应用] batch037-M6-A3-001

模块：M6 | 页码：教材P123

男婴，出生后发现双眼瞳孔区发白，诊断双眼全白内障，眼球发育及全身麻醉情况允许手术。为获得较好视力预后并防治弱视，较适宜的处理策略是？

- A. 3岁后再择期手术
- B. 10周内手术，2~4周内完成另眼 ☒

- C. 仅戴镜矫正，终身不手术
- D. 5岁入学前再手术
- E. 仅遮盖健眼不治本病

答案：B

解析：双眼全白内障或位于视轴中心、混浊明显者出生后10周内手术视力预后更好；一眼完成后应在2~4周内完成另一眼，术后无晶状体眼须屈光矫正并训练视力以防弱视。教材P123。

116. [A4型题 | 分析] batch037-M6-A4-001

模块：M6 | 页码：教材P119

女，65岁，双眼渐进性无痛性视力下降1年余，已妨碍做饭、看电视。查右眼0.1、左眼0.2，晶状体完全混浊呈乳白色、眼底不能窥入，眼压与角膜内皮正常，光定位准确，血糖控制正常。关于其处理，正确的是？

- A. 必须等待视力降至手动才手术
- B. 高龄患者一律禁忌手术治疗
- C. 影响生活质量可行超声乳化联合IOL植入 ☒
- D. 首选长期口服抗白内障药物
- E. 术后不需植入人工晶状体

答案：C

解析：白内障主要适应证是视功能不能满足患者需要而术后可改善视力，本例生活质量已受影响且光定位准确、条件允许，可行超声乳化吸除联合后房型人工晶状体植入；抗白内障药物疗效不确切，无需等到手动。教材P119。

117. [B1型题 | 记忆] batch037-M6-B1-001

模块：M6 | 页码：教材P117

皮质性白内障初期的典型混浊表现是？

- A. 后囊膜下浅层皮质锅巴状混浊
- B. 皮质周边楔形羽毛状混浊 ☒
- C. 核由黄色渐变为棕黑色
- D. 棕黄色核沉于囊袋下方
- E. 前皮质辐射状条纹混浊

答案：B

解析：初发期于周边前后皮质形成楔形、羽毛状、尖端指向中央的混浊，可汇合成轮辐状，散瞳后红光反射见相应阴影。教材P117。

118. [B1型题 | 记忆] batch037-M6-B1-002

模块：M6 | 页码：教材P118

核性白内障随病程进展的典型混浊演变是？

- A. 后囊膜下浅层皮质锅巴状混浊
- B. 皮质周边楔形羽毛状混浊
- C. 核由黄色渐变为棕黑色 ☒
- D. 棕黄色核沉于囊袋下方
- E. 前皮质辐射状条纹混浊

答案：C

解析：核性白内障核混浊由胎儿核或成人核开始，初期黄色，随病程渐呈黄褐色、棕色、棕黑色甚至黑色；A为后囊下白内障，D为过熟期Morgagnian表现，E见于低钙性白内障。教材P118。

119. [X型题 | 理解] batch037-M6-X-001

模块：M6 | 页码：教材P119

下列情况中，属于白内障手术适应证的有？

- A. 视功能不能满足需要且术后有望改善 ☒
- B. 晶状体混浊妨碍眼后节疾病诊治 ☒
- C. 晶状体膨胀诱发闭角型青光眼 ☒
- D. 晶状体引起炎症如晶状体溶解 ☒
- E. 戴镜视力满意且生活未受影响

答案：ABCD

解析：手术适应证包括视功能不能满足需要且术后可改善、混浊妨碍眼后节诊治、有临床意义屈光参差、晶状体引起炎症或膨胀诱发闭角型青光眼等；E项戴镜视力满意、生活质量未受影响属禁忌证。教材P119。

120. [判断题 | 理解] batch037-M6-判断-001

模块：M6 | 页码：教材P125

后囊膜混浊（PCO）是白内障囊外摘除术后最常见的并发症，影响视力时可用Nd:YAG激光行后囊切开。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

答案：A

解析：囊外摘除（含超声乳化）术后残留上皮增生致后囊膜混浊即PCO，为术后最常见并发症，术后3年以上发生率达30%~50%；影响视力时首选Nd:YAG激光后囊切开。教材P125。

M7（20题）

121. [A1型题 | 记忆] batch037-M7-A1-001

模块：M7 | 页码：教材P128

按统计学标准，正常人眼压范围通常为？

- A. 5~10 mmHg
- B. 10~21 mmHg ☒
- C. 21~30 mmHg
- D. 30~40 mmHg
- E. 40~50 mmHg

答案：B

解析：正常人眼压平均值约15.8 mmHg，标准差2.6 mmHg，按均数±2倍标准差定义正常范围即10~21 mmHg；但眼压>21 mmHg不能机械视为病理值，需结合视盘与视野判断。教材P128。

122. [A1型题 | 记忆] batch037-M7-A1-002

模块：M7 | 页码：教材P128

房水生成的主要解剖部位是？

- A. 睫状突 ☒
- B. 小梁网

- C. Schlemm管
- D. 虹膜基质
- E. 脉络膜上腔

答案：A

解析：房水自睫状突生成后，经后房越过瞳孔到达前房，再经小梁网-Schlemm管通道或葡萄膜巩膜通道外流；小梁网、Schlemm管为排出通道，并非生成部位。教材P128。

123. [A1型题 | 理解] batch037-M7-A1-003

模块：M7 | 页码：教材P132

下列哪项不是急性闭角型青光眼的常见诱因？

- A. 暗室停留过久
- B. 情绪激动或紧张
- C. 局部使用抗胆碱药
- D. 长时间阅读疲劳
- E. 局部滴用毛果芸香碱 ☒

答案：E

解析：情绪激动、暗室停留、抗胆碱药物散瞳、长时间阅读疲劳均可使瞳孔散大、周边虹膜松弛而诱发急性发作；毛果芸香碱为缩瞳急救药，用于开放房角，并非诱因。教材P132。

124. [A1型题 | 记忆] batch037-M7-A1-004

模块：M7 | 页码：教材P129

目前公认的眼压测量“金标准”是？

- A. Schiötz压陷眼压计
- B. Goldmann压平眼压计 ☒
- C. 非接触式眼压计
- D. 指测眼压估测法
- E. 回弹式iCare眼压计

答案：B

解析：Goldmann压平眼压计通过测量中央角膜被压平一定面积所需力量来测压，为目前公认金标准；Schiötz为压陷式、非接触式为气流回弹式，均受角膜厚度等因素影响。教材

125. [A1型题 | 记忆] batch037-M7-A1-005

模块：M7 | 页码：教材P129

青光眼临床诊断最基本的检查项目不包括？

- A. 眼压检查
- B. 房角检查
- C. 视野检查
- D. 视盘检查
- E. 眼底荧光血管造影 ☒

答案：E

解析：青光眼最基本检查为眼压、房角、视野、视盘四项；眼底荧光血管造影主要用于视网膜血管性疾病评估，并非青光眼常规诊断项目。教材P129。

126. [A1型题 | 理解] batch037-M7-A1-006

模块：M7 | 页码：教材P132

原发性急性闭角型青光眼的好发人群多见于？

- A. 50岁以上女性远视眼 ☒
- B. 青少年男性近视眼
- C. 婴幼儿双眼大角膜
- D. 中青年男性深前房
- E. 老年男性正视眼

答案：A

解析：急性闭角型青光眼多见于50岁以上老年人，男女比约1:2，患者常有远视、眼轴短、角膜小、前房浅、房角窄、晶状体厚等解剖特征，随年龄增长晶状体增厚、瞳孔阻滞加重。教材P132。

127. [A1型题 | 理解] batch037-M7-A1-007

模块：M7 | 页码：教材P132

急性闭角型青光眼急性发作期，患眼眼压通常？

- A. 低于10 mmHg
- B. 波动于10~21 mmHg
- C. 约21~30 mmHg
- D. 约30~40 mmHg
- E. 常达50 mmHg以上 ☒

答案：E

解析：急性发作期房角突然完全关闭，房水外流骤受阻，眼压常在50 mmHg以上，伴剧烈眼痛头痛、恶心呕吐、角膜上皮水肿、前房极浅、瞳孔中等散大固定。教材P132。

128. [A1型题 | 应用] batch037-M7-A1-008

模块：M7 | 页码：教材P136

前列腺素衍生物（如拉坦前列素）降眼压的主要机制是？

- A. 缩小瞳孔开放房角
- B. 抑制睫状突房水生成
- C. 增加葡萄膜巩膜通道外流 ☒
- D. 减少眼内容积
- E. 改善视神经血供

答案：C

解析：拉坦前列素通过增加房水经葡萄膜巩膜通道外流而降眼压，不减少房水生成，每日傍晚滴眼一次可降压20%~40%，为目前国内外POAG指南一线推荐用药。教材P136。

129. [A1型题 | 理解] batch037-M7-A1-009

模块：M7 | 页码：教材P133

急性闭角型青光眼与急性虹膜睫状体炎的鉴别，错误的是？

- A. 前者角膜后沉着物为棕色色素
- B. 前者前房极浅
- C. 前者瞳孔中等扩大
- D. 前者眼压常偏低 ☒
- E. 前者对侧眼前房浅房角窄

答案：D

解析：急性闭角发作期眼压常 >50 mmHg；而急性虹膜睫状体炎眼压常偏低、瞳孔缩小、KP为灰白色细胞、前房可见房闪及纤维素样渗出。教材P133。

130. [A2型题 | 应用] batch037-M7-A2-001

模块：M7 | 页码：教材P132

58岁女性，傍晚情绪激动后突感右眼剧烈胀痛、头痛伴恶心呕吐、看灯有彩虹圈。检查见右眼混合充血、角膜雾状水肿、前房极浅、瞳孔竖椭圆形散大。最可能的诊断是？

- A. 急性虹膜睫状体炎
- **B. 急性闭角型青光眼急性发作** ✓
- C. 急性细菌性角膜炎
- D. 视网膜中央动脉阻塞
- E. 眼眶急性蜂窝织炎

答案：B

解析：中老年女性+情绪激动诱因+剧烈眼痛头痛恶心呕吐+虹视+混合充血角膜水肿前房极浅瞳孔散大，为急性闭角型青光眼急性发作典型表现；虹膜睫状体炎应瞳孔缩小、KP灰白色、眼压偏低。教材P132。

131. [A2型题 | 应用] batch037-M7-A2-002

模块：M7 | 页码：教材P134

65岁男性，常规体检发现右眼视力1.0，眼底视杯扩大C/D=0.8，双眼C/D差0.3，房角镜检查房角开放，24小时眼压波动较大。最可能的诊断是？

- A. 急性闭角型青光眼
- B. 慢性闭角型青光眼
- **C. 原发性开角型青光眼** ✓
- D. 先天性青光眼
- E. 新生血管性青光眼

答案：C

解析：POAG隐匿起病，前房深浅正常、房角开放，视杯进行性扩大加深、垂直径C/D增大、双眼C/D差 >0.2 ，可伴视野缺损；与闭角型鉴别要点为房角镜下房角是否关闭。教材P134。

132. [A2型题 | 应用] batch037-M7-A2-003

模块：M7 | 页码：教材P142

6个月婴儿，家长发现患儿畏光、流泪、眼睑痉挛，角膜直径13mm呈毛玻璃样混浊，角膜深层见水平条纹状混浊。最可能的诊断是？

- A. 新生儿泪囊炎
- B. 先天性大角膜
- C. 原发先天性青光眼 ✓
- D. 细菌性角膜炎
- E. 先天性角膜营养不良

答案：C

解析：婴幼儿畏光流泪眼睑痉挛三联征+角膜增大（1岁内>12mm）+角膜上皮水肿+后弹力层破裂（Haab纹），为原发先天性青光眼典型表现；原则上一旦诊断尽早行前房角切开或小梁切开术。教材P142。

133. [A2型题 | 理解] batch037-M7-A2-004

模块：M7 | 页码：教材P134

关于原发性开角型青光眼的临床表现，不正确的是？

- A. 发病隐匿常无自觉症状
- B. 早期眼压可在正常范围
- C. 前房深、房角开放
- D. 视杯进行性扩大加深
- E. 典型早期视野为管状视野 ✓

答案：E

解析：POAG典型早期视野缺损为旁中心暗点和鼻侧阶梯，弓形暗点为进展期，管状视野和颞侧视岛为晚期表现；其余选项均为POAG特征。教材P134。

134. [A3型题 | 分析] batch037-M7-A3-001

模块：M7 | 页码：教材P132

62岁女性，2天来每于傍晚出现一过性右眼雾视、虹视、同侧额部酸胀，休息1~2小时后自行缓解，无恶心呕吐。今门诊查双眼视力1.0，右眼角膜轻度雾状水肿，前房极浅，瞳孔稍大，眼压38 mmHg，房角镜下房角大范围关闭。该患者目前所处的临床阶段是？

- A. 临床前期（未发作）
- **B. 先兆期（小发作期）** ☒
- C. 急性发作期
- D. 慢性期（间歇缓解）
- E. 绝对期（终末失明）

答案：B

解析：一过性反复小发作、傍晚出现雾视虹视额部酸胀、休息后自行缓解、不留永久组织损害、眼压约40 mmHg，符合先兆期（小发作期）；急性发作期症状剧烈伴恶心呕吐、眼压>50 mmHg、瞳孔散大固定。教材P132。

135. [A4型题 | 应用] batch037-M7-A4-001

模块：M7 | 页码：教材P136

72岁女性，因“右眼胀痛伴剧烈头痛呕吐6小时”急诊。查体：右眼视力手动/眼前，混合充血，角膜上皮小水珠样水肿，前房极浅，瞳孔中等竖椭圆形散大、光反射消失，眼压55 mmHg。接诊后首要处理是？

- A. 立即行小梁切除术
- B. 立即行激光周边虹膜切开术
- **C. 全身甘露醇+噻吗洛尔+毛果芸香碱** ☒
- D. 局部糖皮质激素+散瞳治疗
- E. 急诊前房穿刺放液

答案：C

解析：急性大发作应先综合药物降压：全升高渗剂（20%甘露醇静滴）+口服乙酰唑胺+局部β受体阻滞剂（噻吗洛尔）+缩瞳剂（毛果芸香碱），炎症重者辅以糖皮质激素；眼压下降房角重新开放后再择期行周边虹膜切开/切除术，广泛粘连者方考虑滤过手术。教材P136。

136. [B1型题 | 记忆] batch037-M7-B1-001

模块：M7 | 页码：教材P136

通过缩小瞳孔、解除周边虹膜对小梁网堵塞而降眼压的药物是？

- **A. 毛果芸香碱** ☒
- B. 噻吗洛尔
- C. 乙酰唑胺

- D. 拉坦前列素
- E. 20%甘露醇

答案：A

解析：毛果芸香碱直接兴奋瞳孔括约肌缩小瞳孔、增加虹膜张力，解除周边虹膜对小梁网的堵塞，使房角重新开放，为闭角型青光眼一线药。教材P136。

137. [B1型题 | 理解] batch037-M7-B1-002

模块：M7 | 页码：教材P136

通过增加房水经葡萄膜巩膜通道外流而降眼压的药物是？

- A. 毛果芸香碱
- B. 噻吗洛尔
- C. 乙酰唑胺
- D. 拉坦前列素 ☒
- E. 20%甘露醇

答案：D

解析：前列腺素衍生物拉坦前列素增加房水经葡萄膜巩膜通道外流，不减少房水生成，降压幅度20%~40%，为POAG一线推荐；噻吗洛尔、乙酰唑胺为减少房水生成药，甘露醇为高渗脱水剂。教材P136。

138. [B1型题 | 记忆] batch037-M7-B1-003

模块：M7 | 页码：教材P132

急性闭角型青光眼一眼急性发作确诊后，另一眼无任何症状但有浅前房窄房角，应诊断为？

- A. 临床前期 ☒
- B. 先兆期
- C. 间歇期
- D. 慢性期
- E. 绝对期

答案：A

解析：急性闭角型青光眼为双侧性眼病，一眼急性发作确诊后另一眼即使无症状亦可诊断为临床前期；临床前期如不治疗40%~80%在5~10年内可能急性发作，应行预防性激光周边虹膜切开。教材P132。

139. [B1型题 | 理解] batch037-M7-B1-004

模块：M7 | 页码：教材P133

高眼压持续过久，眼组织特别是视神经已遭严重破坏，视力降至无光感且无法挽救的晚期病例属于？

- A. 临床前期
- B. 先兆期
- C. 间歇期
- D. 慢性期
- E. 绝对期 ☒

答案：E

解析：绝对期指高眼压持续过久，视神经严重破坏，视力已降至无光感且无法挽救的晚期病例，偶可因眼压过高或角膜变性而剧烈疼痛。教材P133。

140. [X型题 | 理解] batch037-M7-X-001

模块：M7 | 页码：教材P132

急性闭角型青光眼急性发作期的典型体征包括？

- A. 角膜上皮水肿呈小水珠状 ☒
- B. 前房极浅周边部近消失 ☒
- C. 瞳孔缩小呈针尖样
- D. 眼压常达50 mmHg以上 ☒
- E. 混合性充血眼睑水肿 ☒

答案：ABDE

解析：急性发作期典型体征为混合充血、眼睑水肿、角膜上皮小水珠样水肿、前房极浅周边部近消失、瞳孔中等散大呈竖椭圆形光反射消失（而非缩小）、眼压常>50 mmHg，可伴虹视、恶心呕吐。教材P132。

M8 (20题)

141. [A1型题 | 记忆] batch037-M8-A1-001

模块：M8 | 页码：教材P145

玻璃体后脱离（PVD）患者检眼镜下见到的致密混浊环（Weiss环），其来源是？

- A. 玻璃体与黄斑中心凹分离
- B. 玻璃体与晶状体后囊分离
- **C. 玻璃体与视盘附着部分分离** ✓
- D. 玻璃体与锯齿缘部分离
- E. 玻璃体与睫状体平坦部分离

答案：C

解析：Weiss环是玻璃体后皮质与视盘周围附着部分离后，残留的环状混浊物随眼球运动而飘动，是PVD的特征性体征；PVD还表现为闪光感与蜘蛛网样黑影飘动。教材P145。

142. [A1型题 | 理解] batch037-M8-A1-002

模块：M8 | 页码：教材P147

下列疾病中，一般不引起玻璃体积血的是？

- A. 增殖型糖尿病视网膜病变
- B. 视网膜中央静脉阻塞
- C. 外伤性眼球钝挫伤
- **D. 中心性浆液性脉络膜病变** ✓
- E. 视网膜静脉周围炎

答案：D

解析：玻璃体积血多来自视网膜裂孔与脱离、PVD、眼外伤及PDR、CRVO、Eales病等缺血性血管病；中心性浆液性脉络膜病变以脉络膜毛细血管渗漏致浆液性神经上皮脱离为特征，一般不发生玻璃体积血。教材P147。

143. [A1型题 | 记忆] batch037-M8-A1-003

模块：M8 | 页码：教材P153

视网膜中央动脉阻塞（CRAO）典型的后极部眼底表现是？

- A. 黄斑盘状浆液性脱离
- **B. 中心凹樱桃红斑** ✓
- C. 黄斑骨细胞样色素沉着
- D. 黄斑金箔样萎缩斑
- E. 黄斑蛋黄样隆起病灶

答案：B

解析：CRAO时视网膜内层急性缺血水肿呈苍白色混浊，而中心凹因由脉络膜血管供养仍呈红色，形成特征性樱桃红斑；骨细胞样色素沉着见于视网膜色素变性。教材P153。

144. [A1型题 | 记忆] batch037-M8-A1-004

模块：M8 | 页码：教材P151

黄斑中心凹无血管，其营养主要来自？

- A. 视网膜中央动脉
- B. 视网膜睫状动脉
- C. 结膜后动脉
- D. 巩膜表层血管
- E. 脉络膜毛细血管 ☒

答案：E

解析：内核层以内视网膜由视网膜血管系统供应，外层及黄斑中心凹由脉络膜毛细血管供养；中心凹无视网膜毛细血管，故其营养来自脉络膜血管。教材P151。

145. [A1型题 | 理解] batch037-M8-A1-005

模块：M8 | 页码：教材P156

下列各项中，不符合缺血型视网膜中央静脉阻塞表现的是？

- A. 视力明显下降多低于0.1
- B. 视网膜大量融合性出血
- C. 不出现视网膜新生血管 ☒
- D. 相对性传入性瞳孔障碍
- E. FFA大面积无灌注区

答案：C

解析：缺血型CRVO视力多低于0.1、有大量融合性出血与棉绒斑、存在RAPD、FFA见大于10视盘面积无灌注区，且常有新生血管形成，易并发新生血管性青光眼；不出现新生血管属非缺血型特点。教材P156。

146. [A1型题 | 记忆] batch037-M8-A1-006

增殖性糖尿病视网膜病变（PDR）区别于非增殖期的最主要标志是？

- A. 微血管瘤样膨出
- B. 黄白色硬性渗出
- C. 视网膜深层出血点
- **D. 视网膜新生血管** ✓
- E. 黄斑囊样水肿

答案：D

解析：按我国分期，IV期（增生早期）出现视网膜新生血管（NVE）或视盘新生血管（NVD）即标志进入PDR；微血管瘤、硬性渗出、深层出血均属非增殖期表现。教材P159。

147. [A1型题 | 理解] batch037-M8-A1-007

湿性（渗出性）年龄相关性黄斑变性的核心病理改变是？

- **A. 黄斑区脉络膜新生血管** ✓
- B. 黄斑区玻璃膜疣形成
- C. 黄斑区地图样萎缩
- D. 黄斑区色素紊乱脱失
- E. 黄斑区盘状瘢痕形成

答案：A

解析：湿性AMD由Bruch膜变性诱发脉络膜新生血管长入RPE下或神经上皮，引起渗出、出血及盘状瘢痕；玻璃膜疣、色素紊乱及地图样萎缩是干性（萎缩性）AMD的特征。教材P162。

148. [A1型题 | 理解] batch037-M8-A1-008

孔源性视网膜脱离发生的两大病理要素是？

- A. 视网膜炎症与血浆渗出
- B. 眼内肿瘤与液体积聚
- C. 视网膜缺血与新生血管

- D. 玻璃体炎症与机化膜
- E. 视网膜裂孔与玻璃体牵拉 ☒

答案：E

解析：孔源性RD需在视网膜裂孔形成的基础上，液化玻璃体经裂孔并受玻璃体牵拉进入神经上皮下；裂孔多由周边格子样变性及PVD牵拉形成，高度近视、老年人、眼外伤为高危人群。教材P166。

149. [A2型题 | 应用] batch037-M8-A2-001

模块：M8 | 页码：教材P153

患者，男，60岁，晨起突发右眼无痛性视力丧失2小时。查右眼瞳孔散大、直接对光反射消失，后极部视网膜苍白水肿，中心凹呈樱桃红斑。最可能的诊断是？

- A. 视网膜中央静脉阻塞
- B. 年龄相关性黄斑变性
- C. 原发性视网膜色素变性
- D. 视网膜中央动脉阻塞 ☒
- E. 中心性浆液性脉络膜病变

答案：D

解析：突发无痛性视力丧失、瞳孔直接对光反射消失、视网膜苍白水肿伴中心凹樱桃红斑，是CRAO的典型三联征，属眼科急症需尽快抢救。教材P153。

150. [A2型题 | 应用] batch037-M8-A2-002

模块：M8 | 页码：教材P146

患者，女，58岁，1周来左眼闪光感、眼前蜘蛛网样黑影飘动，近日黑影突然增多并出现幕状黑影遮挡。此时首先应警惕的是？

- A. 白内障形成
- B. 视网膜裂孔或脱离 ☒
- C. 开角型青光眼
- D. 慢性葡萄膜炎
- E. 视盘水肿

答案：B

解析：PVD患者若出现色素颗粒、黑影突然增多或幕样视野遮挡，提示玻璃体牵拉形成马蹄形裂孔甚或视网膜脱离，应散瞳三面镜详查眼底，及时激光或手术封闭裂孔。教材P146。

151. [A2型题 | 应用] batch037-M8-A2-003

模块：M8 | 页码：教材P156

患者，男，62岁，右眼视力下降，查见各象限视网膜静脉迂曲扩张、火焰状出血沿静脉分布、视盘及黄斑水肿。关于该患者的处理，错误的是？

- A. 查找并治疗全身病因
- B. 玻璃体腔注射抗VEGF
- C. 缺血型者播散光凝
- D. 定期随访周边眼底
- E. 全身应用强效止血药 ☒

答案：E

解析：CRVO目前尚无有效治疗药物，不宜使用止血药、抗凝药及血管扩张药；应治疗全身病因，黄斑水肿以抗VEGF一线，缺血型无灌注区行播散光凝并随访新生血管。教材P156。

152. [A2型题 | 理解] batch037-M8-A2-004

模块：M8 | 页码：教材P159

患者，女，50岁，糖尿病10年，眼底见后极部散在微动脉瘤、点片状出血及黄白色硬性渗出，未见视网膜新生血管。按我国DR分期属于？

- A. I期轻度非增殖期
- B. II期中度非增殖期 ☒
- C. III期重度非增殖期
- D. IV期增殖早期
- E. VI期增殖晚期

答案：B

解析：I期仅有微血管瘤样膨出；II期为中度非增殖期，可合并视网膜出血、硬性渗出和/或棉绒斑；该患者有微动脉瘤合并出血与硬性渗出且无新生血管，符合II期。教材P159。

153. [A2型题 | 应用] batch037-M8-A2-005

模块：M8 | 页码：教材P162

患者，男，68岁，双眼渐进性视力下降2年，查见黄斑区散在玻璃膜疣、色素紊乱及地图样萎缩，无渗出征象。关于该患者，错误的是？

- A. 属干性萎缩性AMD
- B. 可补充叶黄素抗氧化剂
- C. 常因CNV急性出血致盲 ✓
- D. 视力缓慢进行性减退
- E. 多见于50岁以上人群

答案：C

解析：玻璃膜疣、色素紊乱及地图样萎缩而无出血渗出，为干性（萎缩性）AMD，视力缓慢减退，可补充抗氧化维生素；因脉络膜新生血管急性出血致盲是湿性AMD的特点。教材P162。

154. [A2型题 | 理解] batch037-M8-A2-006

模块：M8 | 页码：教材P167

患者，男，25岁，自幼夜盲，近3年双眼视野进行性缩小。查见视盘蜡黄色、视网膜血管变细、赤道部血管旁骨细胞样色素沉着。最可能的诊断是？

- A. 年龄相关性黄斑变性伴色素紊乱
- B. 中心性浆液性脉络膜病变
- C. 视网膜中央静脉阻塞
- D. Stargardt病
- E. 原发性视网膜色素变性 ✓

答案：E

解析：夜盲为最早表现，伴进行性视野缩小、视盘蜡黄、血管变细及赤道部骨细胞样色素沉着，是原发性视网膜色素变性的典型四联征，ERG早期即显著异常。教材P167。

155. [A3型题 | 分析] batch037-M8-A3-001

模块：M8 | 页码：教材P154

患者，男，65岁，突发左眼视力丧失2小时，无眼痛。查左眼视力无光感，瞳孔散大、直接对光反射消失；后极部视网膜重度苍白水肿并向周边延伸，黄斑区无樱桃红斑，FFA示脉络膜充

盈弱荧光。最可能的诊断是？

- A. 视网膜中央动脉阻塞
- B. 视网膜中央静脉阻塞
- C. 眼动脉阻塞 ✓
- D. 急性球后视神经炎
- E. 湿性年龄相关性黄斑变性

答案：C

解析：眼动脉阻塞时视力常无光感、无樱桃红斑、后极水肿向周边延伸且脉络膜FFA弱荧光、ERG的a波与b波均下降；据此可与有樱桃红斑、脉络膜FFA正常的CRAO鉴别。教材P154。

156. [A4型题 | 应用] batch037-M8-A4-001

模块：M8 | 页码：教材P160

患者，男，45岁，糖尿病15年、血糖控制不佳，3个月来双眼反复玻璃体积血，右眼视力进行性下降。查见视盘及视网膜新生血管、纤维增殖膜牵拉黄斑致视网膜脱离，B超确认无视网膜裂孔。该患眼首选的治疗是？

- A. 单纯观察等待玻璃体积血吸收
- B. 全视网膜冷冻治疗
- C. 单纯巩膜外垫压术
- D. 玻璃体切割术联合光凝 ✓
- E. 口服大剂量止血药

答案：D

解析：PDR伴反复玻璃体积血及牵拉性视网膜脱离、尤其累及黄斑时，应行玻璃体切割术切除纤维血管膜、解除牵拉，并联合全视网膜光凝和/或抗VEGF抑制新生血管；巩膜外垫压主要用于孔源性RD。教材P160。

157. [B1型题 | 记忆] batch037-M8-B1-001

模块：M8 | 页码：教材P166

视网膜出现裂孔，液化玻璃体经裂孔进入神经上皮下引起的脱离，属于

- A. 孔源性视网膜脱离 ✓
- B. 牵拉性视网膜脱离

- C. 渗出性视网膜脱离
- D. 年龄相关性黄斑变性
- E. 原发性视网膜色素变性

答案：A

解析：孔源性视网膜脱离发生在视网膜裂孔基础上，液化玻璃体经裂孔进入神经上皮下使其与RPE分离，治疗以封闭裂孔、复位视网膜为原则。教材P166。

158. [B1型题 | 理解] batch037-M8-B1-002

模块：M8 | 页码：教材P167

无视网膜裂孔，脉络膜血浆经RPE损害处渗漏积聚于神经上皮下所致的脱离，属于

- A. 孔源性视网膜脱离
- B. 牵拉性视网膜脱离
- C. 渗出性视网膜脱离 ✓
- D. 年龄相关性黄斑变性
- E. 原发性视网膜色素变性

答案：C

解析：渗出性（浆液性）视网膜脱离无视网膜裂孔，系血-视网膜外屏障破坏、脉络膜血浆经RPE渗漏所致，见于VKH、葡萄膜炎、Coats病、脉络膜肿瘤等，治疗针对原发病。教材P167。

159. [X型题 | 理解] batch037-M8-X-001

模块：M8 | 页码：教材P153

视网膜中央动脉阻塞（CRAO）的抢救性治疗措施包括？

- A. 眼球按摩降低眼压 ✓
- B. 前房穿刺松动栓子 ✓
- C. 高压氧舱治疗 ✓
- D. 球后注射扩血管药 ✓
- E. 即刻行白内障摘除

答案：ABCD

解析：CRAO为眼科急症，应尽快降眼压（眼球按摩、前房穿刺、口服醋甲唑胺）使栓子后移，并予吸入95%氧与5%二氧化碳混合气体、高压氧、球后注射妥拉苏林等血管扩张

剂；白内障摘除与本病抢救无关。教材P153。

160. [判断题 | 记忆] batch037-M8-判断-001

模块：M8 | 页码：教材P147

玻璃体本身无血管，玻璃体积血的血液均来自周围病变组织。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

答案：A

解析：玻璃体本身无血管，不发生出血；玻璃体积血多由视网膜裂孔脱离、PVD、眼外伤及PDR、CRVO等周围血管性疾病出血进入玻璃体腔所致。教材P147。

M9 (20题)

161. [A1型题 | 记忆] batch037-M9-A1-001

模块：M9 | 页码：教材P171

视神经主要由视网膜哪种细胞的轴突汇集而成？

- A. 视锥细胞
- B. 双极细胞
- C. 视杆细胞
- D. 神经节细胞 ☒
- E. 水平细胞

答案：D

解析：视神经由视网膜神经节细胞的轴索组成，每眼约含110万根轴索，属中枢神经白质，受损后不再生。教材P171。

162. [A1型题 | 记忆] batch037-M9-A1-002

模块：M9 | 页码：教材P179

脑垂体腺瘤压迫视交叉，典型的视野缺损是？

- A. 双颞侧偏盲 ☒

- B. 双鼻侧偏盲
- C. 双眼同侧偏盲
- D. 中心暗点
- E. 向心性缩小

答案：A

解析：视交叉病变最常见病因为脑垂体腺瘤，典型体征为双颞侧偏盲；早期多从颞上象限缺损开始，由下方肿瘤先压迫鼻下纤维所致。教材P179。

163. [A1型题 | 理解] batch037-M9-A1-003

模块：M9 | 页码：教材P172

脱髓鞘性视神经炎最具特征性的眼部症状是？

- A. 眼前黑影飘动
- B. 夜盲进行性加重
- C. 视物变形变大
- D. 眼球转动时疼痛 ✓
- E. 双眼无痛骤盲

答案：D

解析：脱髓鞘性视神经炎多急性亚急性起病，视力进行性下降，常伴眼痛、眼球转动痛，单眼发病多见，患眼出现RAPD。教材P172。

164. [A1型题 | 理解] batch037-M9-A1-004

模块：M9 | 页码：教材P175

前部缺血性视神经病变（AION）的临床表现不包括？

- A. 视盘局限性水肿伴出血
- B. 与生理盲点相连扇形缺损
- C. 渐进性视力下降伴眼痛 ✓
- D. 清晨醒来突发视物遮挡
- E. 相对性传入性瞳孔障碍

答案：C

解析：AION为睫状后短血管缺血致视盘梗死，特点是突发、无痛、非进行性视力下降，多清晨发现；渐进性伴眼痛更符合视神经炎。教材P175。

165. [A1型题 | 记忆] batch037-M9-A1-005

模块：M9 | 页码：教材P188

近视眼用框架眼镜矫正时应选用？

- A. 凸透镜
- **B. 凹透镜** ✓
- C. 柱镜
- D. 棱镜
- E. 平光镜

答案：B

解析：近视眼平行光线聚焦于视网膜之前，需用凹透镜发散光线使焦点后移至视网膜上；凸透镜矫正远视，柱镜矫正散光。教材P188。

166. [A1型题 | 记忆] batch037-M9-A1-006

模块：M9 | 页码：教材P198

老视发生的主要原因是？

- A. 眼轴过长近视加深
- B. 角膜曲率异常散光
- **C. 晶状体调节力下降** ✓
- D. 晶状体混浊密度增高
- E. 房水排出阻力增加

答案：C

解析：老视为年龄增长所致生理性调节幅度下降，多在40~45岁出现视近困难，需用正透镜（凸透镜）补偿调节不足。教材P198。

167. [A1型题 | 理解] batch037-M9-A1-007

模块：M9 | 页码：教材P207

关于眼外肌的神经支配，错误的是？

- A. 内直肌由动眼神经支配
- B. 上直肌由动眼神经支配

- C. 下直肌由动眼神经支配
- D. 上斜肌由滑车神经支配
- E. 外直肌由滑车神经支配 ☒

答案：E

解析：外直肌由展神经（VI）支配，上斜肌由滑车神经（IV）支配，其余眼外肌均由动眼神经（III）支配；外直肌误为滑车神经支配是错误的。教材P207。

168. [A1型题 | 理解] batch037-M9-A1-008

模块：M9 | 页码：教材P214

诊断弱视时，5岁及以上儿童正常视力参考值下限为？

- A. 0.30
- B. 0.40
- C. 0.50
- D. 0.67 ☒
- E. 1.00

答案：D

解析：弱视诊断须结合年龄：3~5岁儿童正常视力下限0.5，5岁及以上为0.67；两眼最佳矫正视力相差 ≥ 2 行，较差一眼诊为弱视。教材P214。

169. [A2型题 | 应用] batch037-M9-A2-001

模块：M9 | 页码：教材P172

女，22岁，1周内右眼视力进行性下降，伴眼球转动痛。查体：右眼视力0.1，瞳孔直接对光反射消失、间接存在，RAPD阳性，视盘轻度充血水肿。最可能的诊断是？

- A. 视网膜中央动脉阻塞
- B. 急性闭角型青光眼
- C. 视神经炎 ☒
- D. 急性虹膜睫状体炎
- E. 表层巩膜炎

答案：C

解析：青年女性急性视力下降+眼球转动痛+RAPD为脱髓鞘性视神经炎典型表现；视网膜动脉阻塞起病更急、无痛且瞳孔对光反射消失但无转动痛。教材P172。

170. [A2型题 | 应用] batch037-M9-A2-002

模块：M9 | 页码：教材P175

男，58岁，有高血压、糖尿病史，晨起发现右眼下方向视物遮挡，无眼痛。查体：右眼视盘局限性水肿伴线状出血，视野见与生理盲点相连的下方扇形缺损。最可能的诊断是？

- A. 前部缺血性视神经病变 ☒
- B. 球后视神经炎
- C. 视盘玻璃膜疣
- D. 眶尖综合征
- E. 视神经脑膜瘤

答案：A

解析：中老年、高血压糖尿病危险因素、清晨突发无痛遮挡、视盘水肿伴与生理盲点相连的扇形视野缺损为非动脉炎性AION典型表现；视神经炎有眼球转动痛。教材P175。

171. [A2型题 | 理解] batch037-M9-A2-003

模块：M9 | 页码：教材P180

患者出现左眼鼻侧、右眼颞侧同时视野缺损，且双眼缺损范围不对称。病变部位最可能在？

- A. 视交叉中部
- B. 左侧视放射
- C. 左侧枕叶
- D. 左眼视神经
- E. 左侧视束 ☒

答案：E

解析：左侧视束病变引起对侧双眼同侧偏盲（左眼鼻侧、右眼颞侧），因交叉与不交叉纤维排列不对称故双眼缺损不一致，可伴Wernicke偏盲性瞳孔强直。教材P180。

172. [A2型题 | 应用] batch037-M9-A2-004

模块：M9 | 页码：教材P206

女，2岁半，家长发现其内斜眼就诊。散瞳验光示中度远视，戴全矫远视眼镜后眼位完全正位。最适宜的处理是？

- A. 尽早行内直肌后徙术
- **B. 坚持全矫配镜并每年验光** ☒
- C. 立即行外直肌缩短术
- D. 手术矫正后再配镜
- E. 不配镜仅门诊验光观察

答案：B

解析：屈光性调节性内斜视发病平均2岁半，有中度远视，戴全矫远视眼镜可完全矫正眼位，此类斜视不适于手术，应坚持配镜并每年重新验光。教材P206。

173. [A2型题 | 应用] batch037-M9-A2-005

模块：M9 | 页码：教材P214

男，4岁，右眼最佳矫正视力0.3，左眼0.8，戴镜后眼位正，眼底无异常。最主要的治疗是？

- **A. 遮盖左眼强迫右眼注视** ☒
- B. 遮盖右眼强迫左眼注视
- C. 双眼同时行精细训练
- D. 立即行斜视矫正手术
- E. 门诊观察暂不处理

答案：A

解析：右眼视力差为弱视眼、左眼为优势眼，常规遮盖优势眼（左眼）强迫弱视眼（右眼）使用，是最有效的单眼弱视治疗方法，同时须精确屈光矫正。教材P214。

174. [A2型题 | 理解] batch037-M9-A2-006

模块：M9 | 页码：教材P201

关于共同性斜视，错误的是？

- A. 眼球运动无明显限制
- B. 斜视角不随注视方向变化
- C. 两眼分别注视时斜视角相同
- **D. 第二斜视角大于第一斜视角** ☒
- E. 一般无复视与代偿头位

答案：D

解析：共同性斜视眼球运动无限制、各注视方向斜视角相等；第二斜视角大于第一斜视角是麻痹性（非共同性）斜视的特征。教材P201。

175. [A3型题 | 应用] batch037-M9-A3-001

模块：M9 | 页码：教材P173

女，28岁，10天前感冒后出现右眼视力下降，眼球转动时疼痛，右眼视力0.05，RAPD阳性，眼底视盘未见明显异常。行视觉诱发电位（VEP）检查，最可能的结果是？

- A. P100波潜伏期缩短
- B. 振幅显著增高
- C. P100波潜伏期延长 ✓
- D. 波形完全消失
- E. 双眼VEP完全对称

答案：C

解析：球后视神经炎早期眼底可无异常，VEP客观显示P100波潜伏期延长和/或振幅降低，对鉴别伪盲有价值；结合感冒后急性视力下降、转动痛、RAPD可诊断。教材P173。

176. [A4型题 | 分析] batch037-M9-A4-001

模块：M9 | 页码：教材P175

女，76岁，1周前晨起突感右眼下方视物遮挡，无眼痛；2天前左眼也出现类似遮挡。查体：双眼视力0.2，双侧视盘苍白水肿伴线状出血，颞动脉走行处可触及索状血管并有压痛。血沉68mm/h，C反应蛋白升高。下一步最关键的处理是？

- A. 门诊随访观察视力
- B. 行视网膜激光光凝
- C. 降眼压药物治疗
- D. 抗生素静脉输注
- E. 立即大剂量激素冲击 ✓

答案：E

解析：高龄、双眼先后发病、颞动脉索状压痛、ESR与CRP升高提示巨细胞动脉炎所致动脉炎性AION，应立即大剂量糖皮质激素静脉冲击以挽救视力并预防对侧眼发作，可做颞动脉活检。教材P175。

177. [B1型题 | 记忆] batch037-M9-B1-001

模块：M9 | 页码：教材P179

脑垂体瘤压迫视交叉中部，典型的视野缺损是？

- A. 同侧眼全盲（单眼盲）
- B. 双侧颞侧视野偏盲 ☒
- C. 不对称性同侧视野偏盲
- D. 对称同侧偏盲伴黄斑回避
- E. 双眼全盲瞳孔对光反射正常

答案：B

解析：视交叉中部病变损害来自两眼鼻侧视网膜的交叉纤维，引起双颞侧偏盲，脑垂体腺瘤为最常见病因。教材P179。

178. [B1型题 | 记忆] batch037-M9-B1-002

模块：M9 | 页码：教材P181

一侧枕叶距状裂皮质脑梗死，典型的视野缺损是？

- A. 同侧眼全盲（单眼盲）
- B. 双侧颞侧视野偏盲
- C. 不对称性同侧视野偏盲
- D. 对称同侧偏盲伴黄斑回避 ☒
- E. 双眼全盲瞳孔对光反射正常

答案：D

解析：枕叶病变表现为双眼一致性（对称）同侧偏盲，因黄斑区双重血供而伴黄斑回避，无视神经萎缩及Wernicke偏盲瞳孔强直。教材P181。

179. [X型题 | 理解] batch037-M9-X-001

模块：M9 | 页码：教材P213

下列各项中，属于弱视常见病因的有？

- A. 单眼恒定性斜视 ☒
- B. 双眼高度屈光参差 ☒
- C. 先天性白内障 ☒

- D. 先天性完全性上睑下垂 ☒
- E. 正视眼长时间阅读

答案：ABCD

解析：弱视由视觉发育期异常视觉经验引起，包括斜视性、屈光参差性、屈光不正性和形觉剥夺性（先天性白内障、角膜混浊、完全性上睑下垂）；正视眼长期阅读不形成弱视。教材P213。

180. [判断题 | 理解] batch037-M9-判断-001

模块：M9 | 页码：教材P182

老视属于屈光不正的一种类型。

- A. 正确
- B. 错误 ☒

答案：B

解析：屈光不正包括近视、远视和散光；老视是年龄增长所致生理性调节力下降，不属于屈光不正范畴，因成像与矫正原理类似而归入本章阐述。教材P182。

M10（20题）

181. [A1型题 | 记忆] batch037-M10-A1-001

模块：M10 | 页码：教材P217

诊断明确的眶深部蜂窝织炎，最首要的处理措施是？

- A. 立即行眶内切开引流
- B. 球后注射抗生素
- C. 全身足量广谱抗生素 ☒
- D. 局部热敷促进化脓
- E. 等待脓肿自行破溃

答案：C

解析：眶深部蜂窝织炎为眶内软组织急性化脓性炎症，可经眼上静脉蔓延至海绵窦危及生命，诊断明确后应立即全身足量广谱抗生素控制感染，同时取结膜囊培养及药敏；眶内脓肿形成后才抽吸或切开引流，而非一开始即切开。教材P217。

182. [A1型题 | 记忆] batch037-M10-A1-002

模块：M10 | 页码：教材P221

甲状腺相关眼病（TED）中，眼外肌受累频率最高的是？

- A. 上直肌
- **B. 下直肌** ✓
- C. 外直肌
- D. 内直肌
- E. 提上睑肌

答案：B

解析：TED眼外肌受累频率依次为下直肌、内直肌、上直肌、外直肌，CT表现为肌腹梭形肥厚而肌肉止点多正常，可借此与特发性眼眶肌炎（肌腹及止点均受累）鉴别。教材P221。

183. [A1型题 | 理解] batch037-M10-A1-003

模块：M10 | 页码：教材P264

与酸烧伤相比，碱烧伤后果更严重，其主要机制是碱能？

- A. 使组织蛋白凝固形成屏障
- **B. 溶解脂肪蛋白并向深层渗透** ✓
- C. 仅引起眼表浅层刺激
- D. 致角膜上皮点状脱落
- E. 迅速升高眼内压

答案：B

解析：酸使蛋白凝固坏死，凝固蛋白形成屏障阻止酸向深层渗透，损伤相对局限；碱能溶解脂肪和蛋白质，与组织接触后很快渗透到深层和眼内，使细胞分解坏死，故后果更严重。教材P264。

184. [A1型题 | 记忆] batch037-M10-A1-004

模块：M10 | 页码：教材P264

发生酸碱化学伤时，现场应立即就地用大量清水反复冲洗，至少持续？

- A. 5分钟

- B. 10分钟
- C. 20分钟
- **D. 30分钟** ✓
- E. 60分钟

答案：D

解析：争分夺秒在现场彻底冲洗是处理酸碱烧伤最重要的一步，应翻转眼睑、转动眼球暴露穹隆部，至少冲洗30分钟，送院后还可再次冲洗，必要时前房穿刺。教材P264。

185. [A1型题 | 理解] batch037-M10-A1-005

模块：M10 | 页码：教材P267

按Keith-Wagener眼底分级法，高血压性视网膜病变IV级的主要标志是？

- A. 视网膜动脉普遍变细
- B. 动静脉交叉压迫
- C. 眼底棉絮状渗出
- **D. 视盘水肿** ✓
- E. 动脉反光带增宽

答案：D

解析：Ⅰ级为血管收缩变窄、动脉反光增宽；Ⅱ级出现动静脉交叉压迫；Ⅲ级在上述基础上有眼底出血、棉絮状渗出；Ⅳ级再伴有视盘水肿，提示病情最重。教材P267。

186. [A1型题 | 记忆] batch037-M10-A1-006

模块：M10 | 页码：教材P269

儿童急性髓系白血病，眶缘触及坚硬肿物伴眼球突出、复视，该肿物称为？

- **A. 绿色瘤** ✓
- B. 皮样囊肿
- C. 炎性假瘤
- D. 海绵状血管瘤
- E. 泪腺混合瘤

答案：A

解析：急性白血病细胞浸润眶内可致眼球突出、运动障碍，部分急性髓系白血病在眶缘触及坚硬肿物，因髓过氧化物酶呈绿色而称绿色瘤（粒细胞肉瘤），提示病情严重、预后不

187. [A1型题 | 理解] batch037-M10-A1-007

模块：M10 | 页码：教材P275

阿-罗瞳孔（Argyll Robertson pupil）的临床表现不包括？

- A. 双侧瞳孔缩小不正圆
- B. 调节集合反射存在
- C. 对扩瞳剂反应差
- **D. 对光反射存在** ✓
- E. 双侧瞳孔不等大

答案：D

解析：阿-罗瞳孔为梅毒累及瞳孔通路所致，表现为双侧瞳孔缩小、不等大、不正圆，反射性瞳孔强直，即无对光反射而保留调节与集合反射，对扩瞳剂反应差；故对光反射存在不属于其表现。教材P275。

188. [A1型题 | 记忆] batch037-M10-A1-008

模块：M10 | 页码：教材P280

下列各项中，不属于WHO“视觉2020”行动确定的六个重点防治眼病的是？

- A. 老年性白内障
- B. 地方性流行性沙眼
- **C. 糖尿病视网膜病变** ✓
- D. 可预防性儿童盲
- E. 屈光不正与低视力

答案：C

解析：“视觉2020，享有看见的权利”行动确定的六个重点为白内障、沙眼、河盲（盘尾丝虫病）、儿童盲、屈光不正和低视力；糖尿病视网膜病变虽为重要致盲眼病，未列入该六大重点。教材P280。

189. [A2型题 | 应用] batch037-M10-A2-001

模块：M10 | 页码：教材P217

患儿5岁，高热39.5℃，左眼睑高度红肿剧痛，眼球突出，球结膜脱出睑裂，眼球各方向运动受限，视力0.1，伴头痛恶心。最可能的诊断是？

- A. 眶深部蜂窝织炎 ☒
- B. 甲状腺相关眼病
- C. 眼眶皮样囊肿
- D. 睑板腺囊肿
- E. 球结膜下出血

答案：A

解析：儿童急性起病、高热中毒症状，合并眼球突出、眼睑高度肿胀、眼球运动障碍及视力下降，为眶隔后（眶深部）蜂窝织炎典型表现，需警惕蔓延至海绵窦；TED多为慢性双眼、皮样囊肿无发热剧痛。教材P217。

190. [A2型题 | 应用] batch037-M10-A2-002

模块：M10 | 页码：教材P264

工人不慎将氢氧化钠溶液溅入左眼，现场最首要、最关键的处理是？

- A. 先滴抗生素再冲洗
- B. 立即就近大量清水冲洗30分钟 ☒
- C. 用眼罩包扎后送医
- D. 等待到院后由医生冲洗
- E. 先用中和液冲洗

答案：B

解析：碱烧伤应争分夺秒在现场就地取材用大量清水反复冲洗，翻转眼睑转动眼球暴露穹隆，至少30分钟，开始冲洗越晚预后越差；不应先包盖或等待到院，亦不推荐现场盲目中和。教材P264。

191. [A2型题 | 理解] batch037-M10-A2-003

模块：M10 | 页码：教材P255

患者右眼被拳击伤后视力下降，裂隙灯下前房积血约占前房1/2，眼压轻度升高。正确的初期处理是？

- A. 立即前房穿刺放血
- B. 立即散瞳活动瞳孔

- C. 卧床半卧位遮双眼制动 ☒
- D. 加压包扎并揉眼
- E. 立即玻璃体切割术

答案：C

解析：前房积血多能自行吸收，初期应卧床、半卧位、遮盖双眼制动并应用激素；扩瞳可能增加再出血风险，宜5天后再考虑；仅当积血多、眼压5~7天不能控制时才行前房冲洗或血块切除。教材P255。

192. [A2型题 | 应用] batch037-M10-A2-004

模块：M10 | 页码：教材P261

青年工人敲击金属时溅入左眼，查见角膜线状伤口、相应虹膜穿孔、前房变浅，疑眼内异物。下列检查属于禁忌的是？

- A. 眼眶CT扫描
- B. 眼部B型超声
- C. X线眼眶摄片
- D. 超声生物显微镜
- E. 磁共振成像 ☒

答案：E

解析：敲击金属致伤应高度怀疑磁性眼内异物，MRI不能用于磁性异物检查，因其磁场可使磁性异物移动而造成眼内二次损伤；可选用X线、B超、UBM或CT定位。教材P261。

193. [A2型题 | 理解] batch037-M10-A2-005

模块：M10 | 页码：教材P268

下列眼部表现中，与糖尿病关系不大的是？

- A. 糖尿病视网膜病变
- B. 晶状体屈光度波动
- C. 虹膜红变新生血管青光眼
- D. 巩膜葡萄肿 ☒
- E. 眼球运动神经麻痹

答案：D

解析：糖尿病可引起DR、糖尿病性白内障、血糖波动所致屈光变化、虹膜睫状体炎、虹膜红变与新生血管性青光眼，并与开角型青光眼相关、可致眼球运动神经麻痹；巩膜葡萄肿并非糖尿病典型眼部并发症。教材P268。

194. [A2型题 | 应用] batch037-M10-A2-006

模块：M10 | 页码：教材P267

高血压患者血压骤升至200/130mmHg，头痛伴视力骤降，双眼视盘水肿，视网膜火焰状出血及棉絮斑。按Keith-Wagener分级属于？

- A. I级
- B. II级
- C. III级
- D. IV级 ☒
- E. 0级

答案：D

解析：在视网膜动脉狭窄、出血渗出的基础上伴有视盘水肿即为IV级，多见于高血压急症（恶性高血压），提示全身重要靶器官受损、预后差。教材P267。

195. [A3型题 | 应用] batch037-M10-A3-001

模块：M10 | 页码：教材P217

患儿8岁，右眼睑红肿疼痛2天，体温39.2℃，查体右眼眼球突出，眼睑高度肿胀，球结膜脱出睑裂，眼球各方向运动受限，视力0.1，眶压高，眼底视网膜静脉扩张，血常规白细胞显著升高。该患者最关键的即刻处理是？

- A. 等待脓肿形成再用药
- B. 立即行眼眶减压术
- C. 全身足量广谱抗生素 ☒
- D. 局部冷敷并口服止痛
- E. 单纯结膜囊冲洗观察

答案：C

解析：本例为眶深部蜂窝织炎急症，诊断明确后应立即全身足量广谱抗生素控制感染并取培养药敏，脱水降眶压、保护角膜；眶内脓肿形成后才切开引流，不应等待脓肿或过早减压手术。教材P217。

196. [A4型题 | 分析] batch037-M10-A4-001

模块：M10 | 页码：教材P258

患者男，30岁，敲击铁片时碎屑击中左眼，当即眼痛、流泪、视力骤降。查体左眼睫状充血，角膜细小线状伤口，相应虹膜处穿孔，前房稍浅，晶状体局限性混浊。次日起左眼疼痛加剧、头痛剧烈，视力降至光感，前房积脓，玻璃体雪球样混浊。该患者最可能的并发症是？

- A. 交感性眼炎
- B. 视网膜母细胞瘤
- C. 外伤性感染性眼内炎 ☒
- D. 急性虹膜睫状体炎
- E. 孔源性视网膜脱离

答案：C

解析：开放性眼外伤合并眼内异物后次日剧烈眼痛头痛、视力严重下降、前房积脓、玻璃体雪球样混浊，为外伤性感染性眼内炎，发展快，需立即散瞳并局部全身大剂量抗生素、玻璃体内注药甚至玻璃体切割；交感性眼炎为伤后2周~2个月另一眼发病的肉芽肿性葡萄膜炎，可资鉴别。教材P258。

197. [B1型题 | 理解] batch037-M10-B1-001

模块：M10 | 页码：教材P269

血红蛋白降至正常30%~50%时，后极部出现火焰状及圆点状视网膜出血、视网膜血管颜色变淡，符合？

- A. 贫血性视网膜病变 ☒
- B. 高血压性视网膜病变
- C. 妊娠高血压视网膜病变
- D. 动脉硬化性视网膜病变
- E. 糖尿病视网膜病变

答案：A

解析：贫血最常见的眼底体征是视网膜出血，呈火焰状或圆点状，多位于后极部，伴视网膜血管色淡、静脉迂曲扩张，与贫血严重程度相关。教材P269。

198. [B1型题 | 理解] batch037-M10-B1-002

模块：M10 | 页码：教材P267

视网膜动脉普遍变细、动静脉交叉压迫，IV级时伴有视盘水肿，符合？

- A. 贫血性视网膜病变
- **B. 高血压性视网膜病变** ✓
- C. 妊娠高血压视网膜病变
- D. 动脉硬化性视网膜病变
- E. 糖尿病视网膜病变

答案：B

解析：高血压使视网膜血管痉挛变窄、管壁增厚，出现动静脉交叉压迫，严重者出血、棉絮斑乃至视盘水肿，即Keith-Wagener分级；动脉硬化性视网膜病变以动脉反光增宽、血管走行平直为主，一般不伴水肿。教材P267。

199. [X型题 | 理解] batch037-M10-X-001

模块：M10 | 页码：教材P279

关于盲与视力损伤及我国防盲治盲，下列说法正确的有？

- **A. 3级盲为较好眼最好矫正视力低于0.05** ✓
- **B. 视野半径 $\leq 10^\circ$ 但 $> 5^\circ$ 可判为盲** ✓
- **C. 白内障是我国致盲主要原因之一** ✓
- D. 全球绝大多数盲目前尚不可避免
- **E. 我国规定每年6月6日为全国爱眼日** ✓

答案：ABCE

解析：WHO标准中3级盲指较好眼最好矫正视力 < 0.05 ；以注视点为中心视野半径 $\leq 10^\circ$ 但 $> 5^\circ$ 为3级盲；白内障为我国致盲主要原因，2001年起白内障盲年手术量已超过新发病例；我国1996年起规定每年6月6日为全国爱眼日。WHO估计全球约80%盲人是可避免的，故D错误。教材P279。

200. [判断题 | 记忆] batch037-M10-判断-001

模块：M10 | 页码：教材P253

怀疑眼球穿通伤并有异物嵌顿时，现场应立即将嵌顿异物拔出后再送医院。

- A. 正确
- **B. 错误** ✓

答案：B

解析：眼球穿通伤现场不应随意清除血痂或拔出、压迫嵌顿异物，以免加重眼内容物脱出和感染，应用硬纸板等遮盖固定、保护眼球后迅速转送有条件医院，并对开放伤注射破伤风抗毒素。教材P253。
